8

להכיר ולהיות מוּכָּר

שיקולים תאורטיים וטכניים ביחס לחשיפה עצמית

בחינה של הספרות האנליטית המצטברת על חשיפה עצמית תעורר בנו תדהמה לנוכח הטרנספורמציה שלא תיאמן שהתחוללה בעולם הפסיכואנליזה תוך שנים אחדות בלבד. רק לאחרונה החל נושא החשיפה העצמית* של האנליטיקאי להופיע בזירה הפסיכואנליטית, אם בנושא לדיונים ורבי־שיח במפגשינו, ואם כתחום ראוי לבחינה בכתבי העת שלנו. אין ספק שבעתיד הקרוב יכללו ספרי לימוד בפסיכואנליזה פרקים על חשיפה עצמית, ומכוני הכשרה יקדישו לנושא זה קורסים וסמינרים קליניים.

נושא החשיפה העצמית הישירה והמכוונת של האנליטיקאי הוא בוודאי אחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת בפסיכואנליזה בת זמננו. אולם שאלת החשיפה העצמית היא תוצר הגיוני מן ההכרה שהתגבשה לאחרונה בחשיבות האינטראקציה והמימוש בפעולה בפסיכואנליזה. כל זמן שהיה זה מובן מאליו שעל האנליטיקאים לשמור על קו בסיסי של אנונימיות, התנזרות וניטרליות, לא היה טעם בשאלות כמו מה לומדים המטופלים על האנליטיקאים שלהם כבני אדם; מה, אם בכלל, יש לומר למטופלים על החוויה הסובייקטיבית של האנליטיקאי, או על תגובתו האישית אליהם כמטופלים; האם חשיפה עצמית של האנליטיקאי יכולה אי־פעם להיות היבט בונה ומועיל של הטכניקה הפסיכואנליטית? כפי ששאל גרינברג (Greenberg, 1995) בכותרתו של דיון שעסק בנושא החשיפה העצמית: "האם זה פסיכואנליטי?"

* יש קושי בתרגום המונח לעברית. לביטוי המקורי, self disclosure, יש קונוטציה משפטית מסוימת (הוא קרוב למה שנהוג לכנות בעברית "גילוי נאות"), בעוד למילה חשיפה יש בעברית קונוטציה אקסהיביציוניסטית במקצת. למעשה, שני הביטויים הם בעייתיים. תרגום חלופי יכול להיות "גילוי עצמי", שהשתמשנו בו לתרגום הביטוי self revelation, אך למושג העיקרי בחרנו ב"חשיפה עצמית" שנמצא היום בשימוש נפוץ.

מבחינה היסטורית, התשובה לשאלתו של גרינברג היתה פסקנית: חשיפה עצמית אינה פסיכואנליטית. פרויד עצמו אמר זאת באופן חד־משמעי! בשעה שפרויד כאדם היה פתוח וספונטני למדי עם מטופליו, הוא ביסס בתוקף ובנחרצות את עקרונות האנונימיות וההתנזרות האנליטיים.

עיינו בפסקה הבאה, מתוך חיבורו של פרויד (1912) על הטכניקה. פסקה זו כוללת את האנלוגיה המפורסמת שלו, אשר מעוררת לא פעם ביקורת, שלפיה על האנליטיקאי להישאר אטום בדומה למראה. אני סבור כי חשיבתו של פרויד על הטכניקה התפתחה במידה רבה בתגובה לחילופי הדברים המוקדמים שלו עם חברו ועמיתו, שנדור פרנצי, אשר במהלך השנים 1911–1912 – לפני שהאנליזה הרשמית הקצרצרה שלו אצל פרויד החלה – דחף את פרויד ללא הרף לעבר פתיחות הדדית, כנות וחשיפה. קראו את העצות הטכניות הבאות של פרויד בעודכם זוכרים את סקירתנו בפרק 6, על תמיכתו של פרנצי בטכניקה רגשית הבונה על הדדיות ופתיחות:

> אין ספק שאנליטיקאים צעירים ונלהבים יתפתו להשקיע חלק ניכר מייחודיותם כדי לסחוף עמם את המטופל ולהניפו אל מעבר למגבלות אישיותו. לכאורה יש מקום לחשוב שמותר בהחלט ואפילו מועיל להתגברות על התנגדויות החולה, שהרופא יאפשר לו להציץ אל תוך פגמיו הנפשיים ואל תוך הקונפליקטים שלו עצמו וכך, על ידי שיתופו את החולה במידע חסוי מתוך חייו, יאפשר לו לפתח יחס שוויוני כלפיו. אמונו של האחד הרי שווה לאמונו של האחר, ומי שדורש אינטימיות מהזולת חייב גם להוכיח לו שהוא מוכן לכך בעצמו.
>
> אלא שביחסים הפסיכואנליטיים דברים מסוימים מתנהלים אחרת מכפי שהיינו מצפים על סמך ההנחות של הפסיכולוגיה של המודע. הניסיון אינו מוכיח את עליונותה של טכניקה רגשית מעין זו. לא קשה גם לראות שבדרך זו אנו עוזבים את הקרקע הפסיכואנליטית ומתקרבים אל הטיפולים הסוגסטיביים. מה שמשיגים בזה הוא שהמטופל מעלה בשלב מוקדם יותר ובפחות קשיים את מה שהוא יודע בעצמו, ואת מה שמתוך התנגדויות קונונציונליות היה עוצר בקרבו עוד זמן־מה. אבל טכניקה זו אינה משיגה מאומה בחשיפת הלא־מודע למטופל; היא רק מקשה עליו עוד יותר לגבור על התנגדויות עמוקות, ובמקרים קשים היא נכשלת שוב ושוב באשר היא מעוררת אצל החולה תיאבון שאין להשביעו, שיגרום לו להפוך את המצב על פיו משום שיגלה שהאנליזה של הרופא מעניינת יותר מזו שלו. גישתו האינטימית של הרופא תקשה גם על פתרון ההעברה – אחת

> המשימות העיקריות של הטיפול – כך שכל שכרו המצופה ייצא בהפסדו. לפיכך אינני מהסס לגנות טכניקה מסוג זה כמוטעית. על הרופא להישאר אטום עבור מטופליו ובדומה למראה, לא להראות דבר זולת מה שמראים לו (פרויד, 1912, עמ' 96-97).

ניתן לקרוא פִּסקה זו כתגובה של פרויד לכמיהותיו האישיות (האנליטיות) של פרנצי לפתיחות וגילוי לב אישיים בינו לבין פרויד. פרויד מטיל דופי ב"טכניקה רגשית" המבכרת הדדיות וחשיפה עצמית אינטימית. הוא מתריע על הסכנות של שימוש הגנתי בהדדיות כהתנגדות לחקירה תוך־נפשית, ומפני מה שייקרא שנים רבות מאוחר יותר "רגרסיה ממאירה" (באלינט, 1968, עמ' 164). פרויד ממליץ בסופו של דבר על גישה שהיא במידה רבה מרוחקת ומנותקת יותר, כמו מראה. על גישה זו בדיוק יקרא פרנצי תיגר בהמשך הדרך. כל אחד משני אנליטיקאים מפלסי דרך אלה פיתח גישה לטכניקה הפסיכואנליטית שתאמה את אופיו ואת מִזגו. האם אנליטיקאים כיום יכולים להשעות את המלצותיו של פרויד לתקופת זמן מַספקת כדי שיגלו בכוחות עצמם את היתרונות והחסרונות של החשיפה העצמית?

בעקבות ניסוייו הרדיקליים של פרנצי באנליזה הדדית, טאבו עוצמתי מנע מהקהילה הפסיכואנליטית לחקור את השימוש בחשיפה עצמית כטכניקה. אף על פי כן, בבריטניה, בעקבות רמזים של ויניקוט (1947) על השימוש השמרני שלו בחשיפת העברה־נגדית, תמכה ליטל (Little, 1951, 1957) בהרבה יותר שימוש חופשי בחשיפה עצמית. באמריקה, המסורת הבינאישית עודדה במידת־מה את השימוש בחשיפה עצמית (ראו בייחוד Tauber, 1954; Singer, 1969, 1977 ו־Searles, 1979), אך אפילו בספרות הבינאישית נכתב רק מעט באופן שיטתי על השיקולים הטכניים של עקרון החשיפה העצמית. בשנים האחרונות, הדיון בנושא זה הלך והתרחב. כמה דוגמאות מצוינות לחשיבה מחדש על חשיפה עצמית בספרות בת זמננו ניתן למצוא אצל בולאס (Bollas, 1987; 1989), גורקין (Gorkin, 1987), ארנברג (Ehrenberg, 1992, 1995), מרודה (Maroda, 1991, 1995), דייויס (Davis, 1994), מיטשל (Mitchell, 1995b) ורניק (Renik, 1995).[33]

מתי תועיל חשיפה עצמית מכוונת של האנליטיקאי? (אני מדגיש חשיפה

33 המחלוקת סביב חשיפה עצמית נסקרה בעבודות אחרות, ואני מפנה את הקורא המעוניין לסקירות ספרות אלה (ראו Burke and Tansey, 1991; Gorkin, 1987; Greenberg, 1995).

עצמית מכוונת ותכליתית, משום שאני מניח כמובן מאליו שאנו תמיד מגלים חלקים מעצמנו, אם אנו מתכוונים לעשות זאת ואם לאו). לאילו מטופלים מועילה חשיפה עצמית? באיזו נקודה באנליזה? לאיזו מטרה? באילו נושאים? באיזה רצף? אילו תנאים יש להבטיח מראש? כיצד יש להכין את המטופל לחשיפה העצמית של האנליטיקאי? מהם יחסי הגומלין בין חשיפות עצמיות אלו לבין פירושים? אילו רמזים מספק המטופל שיסייעו לנו לדעת אם חשיפה עצמית היא במקום? עד כמה ספונטנית אמורה החשיפה העצמית להיות? האם סוגי חשיפה עצמית מסוימים מצריכים מחשבה זהירה בטרם יועמדו במבחן? ואם יש סוגים כאלה, כיצד ניתן לפנות מקום לספונטניות ולמִדְיוּת רגשית? כמה רגש מן הראוי שהאנליטיקאי יבטא במישרין? האם יש נושאים מסוימים שאין לחשוף לעולם – למשל תשוקה מינית או דחפים רצחניים כלפי מטופל? אילו אמצעי זהירות יש לשקול כדי להגן על המטופל מהחודרנות של חשיפותיו העצמיות של האנליטיקאי? כיצד יעריך האנליטיקאי את השפעתה של חשיפה עצמית? כיצד יתמודד האנליטיקאי עם החרדה שהתעוררה בו בעקבות חשיפה עצמית? מהם השיקולים האתיים שיש להביא בחשבון ביחס לחשיפה עצמית?

מה שבאמת נפלא בפתיחת נושא זה לדיון הוא שלראשונה אנו כפסיכואנליטיקאים יכולים לחשוב יחד על חשיפה עצמית בדרך מעודנת, מובחנת ושיטתית. מקריאתי בשיח המתנהל כיום על חשיפה עצמית, אני מתפעל מן הטווח הרחב של הפעילויות המתאימות לקטגוריה של חשיפה עצמית, ומרבגוניות הסגנונות האישיים והגישות הטכניות שיכולים להתפתח כאשר אנליטיקאים בעלי אישיויות שונות ומחויבויות תאורטיות שונות, העובדים במגוון רחב של מסגרות ועם אוכלוסיות שונות של מטופלים, מתנסים בחשיפה עצמית ומדווחים על ממצאיהם.

הדגמה קלינית

אציג עתה אנקדוטה, רגע מעבודתי הקלינית עם גבר צעיר, הממחישה את השימוש בחשיפה עצמית בשירות ה"פירוש". אם לנסח זאת בשפה קצת פחות טכנית, וינייטה זו מתארת את אחת מדרכי העבודה האנליטית האופייניות לי: לפעמים אני חושב בקול רם עם מטופלי בלי לדעת בדיוק לאן נודדות מחשבותי; מבטא אסוציאציות באופן סלקטיבי. מכיוון שחשיפות עצמיות יכולות להופיע במגוון כה רחב ובצורות כה רבות, אני מודע לכך שאנקדוטה זו היא לא יותר מהמחשה; אין היא מייצגת את החשיפות העצמיות ככלל, ואין לה ערך של

הוכחה או תוקף מדעי. אני מציע אותה כנקודת פתיחה שתסייע לנו לפתוח בשיחה על חשיפה עצמית.

מטופל זה יודע שאני נשוי, אך בשנות עבודתנו המשותפת באנליזה שאל אותי ישירות רק לעתים נדירות ביותר על אשתי או על נישואי. באחת הפגישות האחרונות הוא תיאר את חששותיו שמא הקשר שלו עם חברתו, שנעשה רציני למדי, לא ישרוד את התחושות שזיהה לאחרונה של אמביוולנטיות כלפיה. הוא היה רגשני מהרגיל, והביע בדמעות את דאגתו כיצד יוכל להמשיך את המערכות עם חברתו, עכשיו כשהוא יודע שיש דברים חשובים אצלה שאין הוא אוהב. הערתי כמה הערות מאתגרות, ושאלתי מדוע לא יוכל לשמור על קרבה אתה רק משום שיש בה כמה דברים שאינם לרוחו. פעמים רבות בעבר דנו בצד השני של המטבע, כלומר בציפייתו שמישהי חייבת לאהוב בו כל דבר, שאם לא כן תנטוש אותו. אם היא "לא אוהבת את החרא שלו", הרי שלא תוכל לאהוב אותו.

אך כעת דיברנו על המצב ההפוך: האם יוכל להמשיך לאהוב מישהי שיש בה דברים שאינו אוהב? לפתע שאל אותי בטון מאתגר ומתגרה, אך עם זאת מפציר: "יש דברים חשובים באשתך שאתה לא אוהב?" הייתי מופתע ונבוך, אך לאחר רגע של היסוס עניתי: "כן, יש דברים חשובים שאינני אוהב באשתי". לאחר הפוגה קצרה של חשיבה הוספתי: "ומה שאולי משמעותי יותר, יש דברים חשובים בי שאשתי לא אוהבת". אחרי רגע נוסף של שתיקה והרהור המשכתי: "אתה יודע, יש דברים חשובים בי שאני בעצמי לא אוהב – למה היא צריכה לאהוב אותם?"

מבלי להיכנס לתיאור מפורט כיצד נמשכה התרחשות זו (פירוט שבכל מקרה **לא** יוביל למסקנות חד־משמעיות ביחס ליעילות התערבותי), אומר כי הרגשתי אז, ואני סבור גם כעת, שהמטופל שלי חווה התערבות זו כמועילה למדי. אפיזודה זו הביאה אותנו כמובן לחקור את הנושא בצורה ישירה בהעברה. עד כמה הוא יכול לזהות בי דברים חשובים שאינו אוהב, ולהמשיך להרגיש שאני טוב בשבילו כאנליטיקאי? עד כמה אני יכול לא לאהוב דברים חשובים ביחס אליו, ועדיין לחבב אותו בכנות ולרצות לעזור לו? אין ספק שתגובתי טִשטשה מעט ממדים נוספים של מה שהמטופל ניסה לשדר. לדוגמה, ייתכן כי תגובתי השהתה – ולו לזמן־מה – את התמודדותו עם המחשבה הנוראה שאולי באמת יחליט לוותר על הקשר הזה, ויעמוד בפני אובדן חברתו ובפני האשמה על נטישתה. אולי העברתי לו את המסר (הלא־מודע) שעדיף שיישאר עוד בקשר עם אישה זו לפני שיחליט להתייאש ממנה ולהמשיך הלאה. ואולי גם שידרתי (שוב בצורה לא־מודעת) שיפעל כך ביחס אלי ולאנליזה.

כיצד עלינו לחשוב על התערבות מסוג זה? האם זהו גילוי עצמי? כן, במובן המחמיר של המונח, ודאי שכן. במקום "לעשות אנליזה" לשאלתו, עניתי לו בצורה ישירה ואף נידבתי מידע נוסף. יתר על כן, היה זה מידע אישי, שכן חשפתי מחשבות ורגשות מסוימים הנוגעים לאשתי, לי ולקשר בינינו. סיפקתי למטופל שלי באופן סמלי אפשרות להציץ לסצנה הראשונית, לצפות במשהו מהדינמיקה בין אשתי לביני. האם היה עלי לחשוש שמא בכך גרמתי לו סיפוק, או גירוי יתר?

מצד שני, האם באמת גיליתי בכלל משהו אישי? אולי לא. כל מערכות היחסים האנושיות הן אמביוולנטיות; אף אחד אינו אוהב מישהו אחר באופן מוחלט, אף אחד אינו אוהב את עצמו באופן מוחלט, וגם אינו צריך לחוש מחויב לכך. ניתן לראות אפוא את הערותי כפירוש למטופל, פירוש שלבש צורה של חשיפה עצמית. מבלי לנסח זאת במפורש, אמרתי למטופל משהו כמו:

"ניתן לצפות שאנשים ירגישו אמביוולנטיים כלפי אלו שהם אוהבים ושהכי קרובים אליהם. נראה שיש לך אמונה מוטעית שאם תחווה מחשבות שליליות או רגשות שליליים כלפי מישהו, זה אומר שאינך באמת אוהב אותו. עם סטנדרטים כאלה ברור שלא תוכל לאהוב אף אחד, או להרגיש שמישהו אוהב אותך. ומאחר שכך אתה מרגיש, אינך מסוגל לראות משהו בעצמך שאינך אוהב, שכן אם זה יהיה המצב תיאלץ להגיע למסקנה שאינך אוהב את עצמך בכלל. לכן אתה מכחיש רגשות שליליים אלו ונמנע מלהכיר בפגמים כלשהם בעצמך, בדיוק כפי שאתה עושה ביחס לחברה שלך".

אם המטופל שלי הצליח לשמוע בתגובתי פירוש מובלע זה, הוא ודאי גם הבין – שהרי עסקנו בנושא זה שוב ושוב – שהקונפליקט שלו קשור לאי־היכולת של משפחתו להכיר בקונפליקט או במחלוקת כלשהי ביניהם ולשוחח עליהם. הוא ודאי הבין גם שהקונפליקט שלו מפריע לו לחשוב עלי באופן ביקורתי, ומשפיע על האופן שהוא תופס ביקורת כלשהי שאני מותח עליו. נוסף על כך, מן ה"פירוש" שלי משתמע בבהירות הרעיון שהוא אינו היחיד שמרגיש אמביוולנטיות כלפי אלו שהוא אוהב, שתחושת אמביוולנטיות היא דבר רגיל ובלתי נמנע. למען האמת, בהתחשב בהתקדמות הטיפול מנקודה זו והלאה, אני די בטוח שהמטופל שלי אכן שמע את דברי ברוח דומה מאוד לזו שתיארתי כאן; אך משום שהדברים היו אישיים, ספונטניים, מבודחים מעט, חיים מבחינה רגשית, ועסקו בי יותר מאשר בו, נראה שהם הגיעו אליו יותר מאשר פירושים קודמים.

אולם המטופל שלי חש עצוב ומפוחד מאוד, והראה לי את עוצמת תחושותיו; ייתכן שבניסיוני להיות קליל פשוט הסחתי את דעתו מרגשות כואבים אלו.

מתגובתי יכול היה להשתמע גם הרעיון שבניגוד אליו אין לי כל קושי להכיר בכך שמערכות היחסים שלי אינן מושלמות, ושיש לי מידה מסוימת של הומור ביחס לעצמי. אולי התרברבתי בפני המטופל שלי בכך שאני פחות הגנתי ממנו. הייתי תחרותי במסר שלא רק שאני נמצא בקשר, אלא גם אינני מתייחס לעצמי בכובד ראש כמוהו. בסופו של דבר הצליח המטופל שלי לרמוז לי שקלט שהיה בינינו מאבק כוחות, ושבדרך שהפגנתי את עליונותי עליו אף גרמתי לו לחוש מאוים. אם לסבך עוד יותר את מצב הדברים, היה למטופל קשה במיוחד לעמת אותי עם היבט זה באישיותי, בדיוק משום שחווה אותי כמדבר בכנות ומתוך כוונות טובות.

כמו כל התערבות אחרת, מה שאמרתי למטופל חשף יותר מכפי שהיה בכוונתי המודעת לחשוף. בכך ביטאו דברי היבט של הסובייקטיביות שלי, שהמטופל שלי ואני היינו עשויים להכיר או לא להכיר. העובדה שהתערבות כזו מצריכה אולי עבודה נוספת, משום שהיא חושפת משהו ביחס לסובייקטיביות של האנליטיקאי, אינה מבדילה אותה מכל פירוש אחר, שעשוי להשפיע באופן דומה גם אם בצורה סובטילית יותר. ייתכן שעלינו לחשוב על חשיפות עצמיות מסוימות כעל "פירושים מובלעים" או "חשיפות עצמיות בשירות הפירוש". בעקבות הצעתו של אוגדן (2011, עמ' 102-119), אפשר לחשוב על חשיפות עצמיות כעל סוג של "פעילויות פרשניות", אף שברור לי שאוגדן אינו תומך בחשיפה עצמית או שואף לקדמה. אף על פי כן, טענתו היא כי במקרים רבים פירושים מועברים בדרכים שאינן סימול מילולי ישיר.

התנגדות שהועלתה כלפי סוג כזה של התערבות (Rothstein, 1995) גורסת כי הפקתי רווחים מהעברה אל הורה מתירני במקום לנתח העברה זו באופן אנליטי, ובכך עודדתי את התלות של המטופל והפרעתי להתפתחות יכולתו האוטונומית לאנליזה עצמית. בעיקרו של דבר אמרתי למטופל: "אל תדאג, כולנו – גם אתה וגם אני – אמביוולנטים כלפי מערכות יחסים, וזה בסדר". ניתן לצפות כי אישור מעין זה יביא לריפוי העברתי,* או לריפוי המבוסס על סוגסטיה בינאישית, אך לא לריפוי המבוסס על "שינוי מבני פנימי".

רוטסטיין מעלה נקודה חשובה, אך בעיני אין בדבריו משום התנגדות מכרעת לסוג כזה של התערבות. קודם כול, שודשי התנגדותו נעוצים בתאוריה על הנפש שאינני תומך בה. כלומר עמדתו מבוססת על מודל הרואה את האדם כ"אינדיבידואל", ואת הנפש כ"אוטונומית". כפי שטענתי בספר זה כולו, אני

* transference cure – מושג רווח בפסיכואנליזה הקלאסית, המרמז שהריפוי תלוי בקשר עם המטפל, ולכן אינו בר קיימה.

מעדיף מודל של הנפש שהוא פחות אינדיבידואליסטי ויותר התייחסותי, שהנפש קיימת בו תמיד בקשר עם אחרים, היא תמיד תלויה במידה מסוימת, ולעולם אינה אוטונומית לגמרי. בשעה שקידום האוטונומיה של המטופל הוא ערך חשוב מאוד, אין זו בעיני המטרה הסופית. חשוב להעריך קשר וקִרבה, לא פחות מאשר אוטונומיה ועצמאות. מה שחשוב בכל התערבות שהיא, לרבות חשיפה עצמית, אינו אם היא מקדמת אוטונומיה או קשר, אלא אם היא פותחת או חוסמת חקירה אנליטית.

שנית, אני בטוח שהצדק עם רוטסטיין, ואכן פעלה פה העברה הורית. עם זאת, נדמה שהוא רומז שאילולא עניתי על שאלת המטופל, אילולא חשפתי את עצמי, יכולתי למצוא דרך להימנע ממימוש בפעולה של ההעברה. אך אילו סירבתי לענות על שאלת המטופל, האם לא הייתי מממש אז בפעולה גִרסה אחרת כלשהי של העברה הקשורה לאבי המטופל? מי יכול לומר איזו התנהגות יחווה המטופל ככוחנית ואבהית יותר? תהיה תגובת האנליטיקאי אשר תהיה, יסוד כלשהו של סוגסטיה נוכח תמיד בעבודתנו. שוב, אינני מקבל את ההבחנה המוחלטת בין "ריפוי העברתי" לריפוי המבוסס על "שינוי מבני". בתובנה ובפירוש יש תמיד ממד סוגסטיבי, ואינטראקציה יכולה בהחלט להעביר תובנה. שינוי "מבני" אנליטי מושג באמצעות פעולה משותפת של תובנה וקשר כאחד. מעמדתו של רוטסטיין משתמע כי הוא מכיר דרך (הטכניקה הקלאסית) להימנע משימוש בסוגסטיה. כאן אנו חלוקים.

שלישית, עלינו לשקול את משמעות התערבותי למטופל המסוים. למשל, אביו של בחור צעיר זה לא נטה לשתף אותו ברשמים מסוג זה. הוא לעולם לא היה מודה שיש היבט שלו שאשתו לא אוהבת, או פן באשתו שהוא אינו אוהב. לכן, כאשר עניתי כפי שעניתי, הייתי בבירור שונה מאביו. לא אימצתי במודע תפקיד מלאכותי; ניסיתי לבטא מה שחוויתי כאסוציאציה מפתיעה וספונטנית. כאשר אמר לי המטופל מאוחר יותר שזה משהו שאביו אף פעם לא היה אומר, אמרתי לו שאולי ניסיתי להראות לו שאני לא לגמרי דומה לאביו.

במקום להימנע ממימוש בפעולה מעין זה, אני מעדיף ליצור אקלים אנליטי שבו אוכל להיות סובלני לטווח רחב יותר של התנהגויות בעצמי מכפי שמקובל באופן מסורתי, ואני משתדל לנתחן באופן אנליטי עד כמה שניתן; עם זאת אני יודע שלא אוכל לעשות לכולן אנליזה מלאה. השתתפות ספונטנית ואישית יותר מעמידה את האנליטיקאי בסיכון שהרבה מעצמו ייחשף למבטו הבוחן של המטופל. אך אם האנליטיקאי מסוגל לשמור על פתיחות למשוב זה מהמטופל, כי אז השתתפות כזו של המטופל בטיפול תקדם לא רק קִרבה רבה יותר, אלא גם אוטונומיה אנליטית רבה יותר. אחרי ככלות הכול, התערבותי התרחשה לאחר

שנים רבות של עבודה על בעיה זו, ובהקשר של הזדמנויות רבות שפירשנו בהן דינמיקות אלה באופן מסורתי. בתנאים אלו יהיה מועיל לאזן בין האנונימיות והריחוק של הפירוש המסורתי לבין השפעת ההשתתפות האישית והספונטנית יותר.

חשיפה עצמית היא בלתי נמנעת

לא אוכל להדגיש יתר על המידה את הרעיון, **שחשיפה עצמית אינה אפשרות העומדת בפני האנליטיקאי; היא בלתי נמנעת!** בפרק זה אנו עוסקים באותן התערבויות החושפות היבטים מהסובייקטיביות של האנליטיקאי באופן מגמתי ומכוון. אך דיוננו כאן בסוג זה של חשיפה עצמית מכוונת אינו צריך לטשטש את טבעו הבלתי נמנע של הגילוי העצמי המתמשך, המילולי והלא־מילולי. תקשורת על המצבים הפנימיים של המטפל מועברת ללא הרף למטופל. כל התערבויותינו הן התנהגויות, לרבות החלטותינו שלא להתערב; גם שתיקותינו הן התנהגויות, וכל התנהגות היא תקשורת.

וצלוויק, בוולס וג'קסון (Watzlawick, Bavelas, & Jackson, 1967) מנסחים כך את האקסיומה הראשונה של תאוריית התקשורת:

> ראשית, להתנהגות יש מאפיין שאין בסיסי ממנו, ועל כן פעמים רבות אינו נלקח בחשבון: אין בנמצא ההפך מהתנהגות. במילים אחרות, אין דבר כזה אי־התנהגות, או במילים פשוטות עוד יותר: אי אפשר **לא** להתנהג. ואם נקבל את ההנחה שבמצב של אינטראקציה לכל התנהגות יש ערך של מסר, כלומר היא תקשורת, מכאן שכלל שאדם יתאמץ אין ביכולתו **לא** לתקשר. פעילות או אי־פעילות, מילים או שתיקה – לכולם יש ערך של מסר: הם משפיעים על אחרים, ואלה בתורם אינם יכולים **לא** להגיב לתקשורת זו, וכך יוצרים בעצמם תקשורת (עמ' 49).

לסיכום, האקסיומה הראשונה של תאוריית התקשורת היא: "**אדם אינו יכול לא לתקשר**" (עמ' 51). האקסיומה השנייה של תאוריית התקשורת, הנגזרת מעבודתו של בייטסון (Bateson, 1972), היא שכל תקשורת כרוכה במטא־תקשורת. בכל תקשורת יש היבטים של דיווח או תוכן, והיבטים של הוראה או יצירת קשר. לפיכך כל תקשורת מגדירה את הקשר ומעבירה תוכן. מהגדרת הקשר משתמע כיצד יראה אדם את עצמו ואת האחר. ברמה המטא־תקשורתית, תקשורת מעבירה מידע כדוגמת "כך אני רואה אותך", "כך אני רואה כיצד אתה

רואה אותי", "כך אני רואה כיצד אתה רואה את ראייתי אותך", וכך הלאה...

על ידי הרחבת עקרונות אלו של תאוריית התקשורת והחלתם על המצב האנליטי (כפי שעשה לראשונה לוונסון; Levenson, 1983), אנו יכולים לומר שהאנליטיקאי תמיד מתנהג בדרך כזו או אחרת, ועל כן הוא תמיד מְתַקשר, ובכך מגדיר ומגדיר מחדש ללא הרף את הקשר שלו עם המטופל. על בסיס הנחות יסוד אלו של תאוריית התקשורת, אנו משערים שהאנליטיקאי אף פעם אינו ניטרלי או אנונימי, אלא תמיד חושף את עצמו, ובהחלט **משפיע על הקשר עם המטופל** ומַבנה בשיתוף אִתו את מערכת היחסים שלהם. במילותיו של פייזר (Pizer, 1992), המטופל והאנליטיקאי תמיד "נושאים ונותנים" זה עם זה מי ומה הם יהיו זה לזה. בכל תקשורת שלהם איש עם רעהו אומרים המטופל והאנליטיקאי איש לרעהו משהו כמו "תוכל לעשות ממני כך וכך, אך לא זה וזה"; "אני מוכן להיות זה וזה עבורך, אך לא כך וכך" (עמ' 218). כאשר אנו שוקלים חשיפה עצמית מכוונת מצד האנליטיקאי, אל לנו להתעלם מן ההכרח בגילויים עצמיים מתמשכים, המתרחשים בהיסח הדעת. הקו בין חשיפה עצמית מכוונת לחשיפה עצמית המתרחשת מבלי משים (בין חשיפה עצמית מודעת ללא־מודעת) הוא עמום ביותר.

יתרונות וחסרונות של חשיפה עצמית

קיימות כמה סיבות טובות מאוד לאנליטיקאי שלא לחשוף את עצמו בפני מטופל. בין הסיבות שניתנות בדרך כלל: הדבר מסבך את הטיפול שלא לצורך; מעמיס את בעיות האנליטיקאי על המטופל; מסיט את תשומת הלב מדאגותיו של המטופל; ומשקף את צרכיו של האנליטיקאי ולא של המטופל. מנקודת מבט קלאסית, הדבר אינו עולה בקנה אחד עם רעיון "המסך החלק". הוא עלול לגרום לסיפוק יתר של המטופל; זוהי צורה של "ביטוי בפעולה" מצד האנליטיקאי; ואולי חשוב מכול, הדבר מטשטש את אופי ההעברה של המטופל. כיוון שההעברה נתפסת במודל הקלאסי כעיוות הנובע מתוך המטופל, ומבוסס על התקות מאובייקטים קדומים, כל תקשורת מצד האנליטיקאים על עצמם תפריע לנביעה ספונטנית זו מתוך המטופלים, או עלולה להקשות על הבחנה היכן מסתיים העיוות ומתחילה המציאות הבינאישית. מידע רב מדי ביחס לאנליטיקאי עלול לעכב או להגביל את הפנטזיות של המטופל ואת תגובותיו. אף שאינני חושב כמובן שכך פועלת ההעברה, אני בהחלט סבור שיש הצדקות לשימוש זהיר בחשיפה עצמית. חשיפת ההעברה־הנגדית, כמו כל טכניקת התערבות אחרת או כל סוג אחר של השתתפות האנליטיקאי, עלולה בהחלט לפעול נגד הטיפול.

התנגדות נוספת לחשיפה העצמית של האנליטיקאי (הנשמעת אפילו מפיהם של אנליטיקאים התייחסותיים בני זמננו) היא כי הדבר נוטה לשבש את המרחב המעברי של הפסיכואנליזה, מפני שהוא הופך לקונקרטי את מה שמן הראוי שייוותר בתחום הסמלי (לרב־שיח מעניין בנושא זה, ראו Benjamin, 1994; Davies, 1994; Gabbard, 1994). למשל, אם מטופל חושד שהאנליטיקאית רוצה להרוג אותו, פנטזיה זו נותרת בתחום הסמלי; אך אם האנליטיקאית אומרת למטופל שהיא רוצה להרוג אותו, וידוי זה גורם לקונקרטיזציה של הפנטזיה, והמרחב הפוטנציאלי נסגר במקום להיפתח. סגירת המרחב האנליטי משמעה הגבלת החופש של המטופל ליצור את מה שיש לו צורך ליצור במצב האנליטי. אך עלינו לזכור שיצירה אנליטית זו של המטופל היא תמיד אשלייתית. למטופל אין אף פעם חופש כזה באמת, שכן האנליטיקאי תמיד ממלא תפקיד בעיצוב המרחב האנליטי; ו"המרחב הפוטנציאלי", שהוא מהות הפסיכואנליזה, נוצר הן על ידי המטופל והן על ידי האנליטיקאי באמצעות השתתפותם ההדדית. האנליטיקאי תמיד יוצר את המרחב האנליטי עם המטופל, ודיבור על סגירת מרחב זה על ידי האנליטיקאי – או פתיחתו – הוא בעייתי; זוהי יצירה משותפת. כאשר האנליטיקאי מגלה מה הוא מרגיש הוא אכן מעצב את המצב האנליטי באופן מסוים ולא באופן אחר; אך גם תחושות האנליטיקאי שאינן מדוברות עם המטופל מעצבות את המרחב האנליטי. האינטראקציה האנליטית פותחת אפשרויות מסוימות וחוסמת אחרות. האנליטיקאי אינו יכול לא להשתתף בעיצוב המרחב האנליטי; במובן זה, אנליטיקאים תמיד מגבילים את החופש האנליטי של מטופליהם.

אך האם ניתן להפיק מחשיפה עצמית תועלת שתצדיק את הסיכון הכרוך במגרעותיה? גורקין (Gorkin, 1987) טוען כי חשיפות של העברה־נגדית הנעשות בצמצום ובאופן סלקטיבי יכולות לספק כוח מניע טיפולי. הוא מונה את הטיעונים הבאים התומכים בחשיפה עצמית סלקטיבית: (1) חשיפות עצמיות יכולות לתקף את תחושת המציאות של המטופל. (2) בכוחן לסייע באישור הכֵנוּת והאותנטיות של המטפל. (3) הן מראות כי המטפל אינו כה שונה מהמטופל, שהמטפל גם הוא אנושי ויש לו העברות. (4) חשיפות עצמיות מבהירות את טבעה של השפעת המטופל על המטפל ועל בני אדם בכלל. (5) חשיפות עצמיות יכולות לקדם פריצת דרך טיפולית במקרים של מבוי סתום והתבצרות בהתנגדות.

יש אנליטיקאים, בייחוד בין אלו המושפעים מהתאוריה הבינאישית, הטוענים כי חשיפה שקולה של חווייתו הסובייקטיבית של האנליטיקאי (כאשר המטופל והאנליטיקאי חולקים רעיונות, התבוננויות, הבחנות, ואולי חשוב מכול תגובות

רגשיות, ודנים עליהם), מובילה ליצירת "חקירה משותפת" (Chrzanowski, 1980) המעשירה את האנליזה ב"נתונים" שתורמים הן המטופל והן האנליטיקאי. חז'נובסקי כותב: "כלי טיפולי חשוב [של הפסיכואנליזה הבינאישית] טמון בשיתוף מבוקר של המטופל בחוויות של העברה־נגדית" (עמ' 141).

שיתוף סלקטיבי בהעברה־הנגדית, נוסף על הרחבת בסיס הנתונים האנליטי, מקדם גם מפגש ומעורבות רגשיים בינאישיים. גולדסטיין (Goldstein, 1994), אשר כתבה על חשיפה עצמית מפרספקטיבה של פסיכולוגיית העצמי (תיאור המקרה שלה נדון בפרק הקודם) אף היא קבעה כי ניתן להתייחס לשימוש בחשיפה עצמית כאל צורה של התכוונות אמפתית והיענות לצורכי זולתעצמי. ארנברג (Ehrenberg, 1995), הכותבת מתוך השקפה בינאישית עכשווית, טוענת כי חשיפה שקולה של ההעברה־הנגדית מעודדת מטופלים לשתף פעולה באופן מלא יותר בחקירת האינטראקציה האנליטית המֵדית. היא מבטאת עמדה רדיקלית, שלפיה חשיפה מחושבת של ההעברה־הנגדית יכולה לקדם מעורבות אנליטית אצל כל המטופלים.

ג'יקובס (Jacobs, 1995), שעבודתו על מימוש בפעולה נדונה בהרחבה בפרק הקודם, טוען – בדומה למחברים רבים התומכים בחשיפה עצמית מרוסנת וזהירה – כי לעתים העברת מסר כלשהו למטופל בצורת חשיפה עצמית מאפשרת למטופל לחוות את דברי האנליטיקאי כאישיים ואותנטיים יותר, ואז השפעתם על המטופל רבה יותר. אך האין אלה בדיוק אותם טיעונים שפרויד (1912) הציג כמשקפים "פסיכולוגיה של המודע", והזהיר כי השיטה הפסיכואנליטית אינה מאשרת את תוקפם? האם עלינו לזנוח את עצתו של פרויד, ובמקומה לצדד בגישה רגשית כדוגמת האנליזה ההדדית של פרנצי?

גרינברג (Greenberg, 1995), שעקרונית **אינו** מתנגד לחשיפה עצמית, ובמקום אחר (Greenberg, 1991) הביא דוגמאות לתועלת שבה, הציג מקרה של מטופל שביקש ממנו פיסת מידע פשוטה יחסית, אם קיבל הודעה שהמטופל השאיר לו במענה הקולי. גרינברג ממחיש כי ההימנעות ממסירת מידע פשוט זה (אי־החשיפה) הובילה לאינטראקציה עוצמתית עם המטופל, שבסופו של דבר התגלתה כקונסטרוקטיבית וכמחוללת שינוי. במקרה זה, סירוב האנליטיקאי לחשוף את עצמו ביטא וכונן את הסובייקטיביות העצמאית שלו טוב יותר מכפי שיכלה לעשות זאת חשיפה.

אני טוען לפיכך כי החירות של האנליטיקאים להשתמש בעצמם בצורה מלאה – שימוש הכולל הן את האפשרות לחשיפה עצמית מוגברת והן את הבחירה שלא לחשוף – מספקת את התנאים המיטביים להבנה קוגניטיבית פרשנית, כמו גם למעורבות רגשית בינאישית. כדי להתנהל היטב בחיים חשוב

לשמור על גמישות, להשאיר אפשרויות פתוחות. כך גם בנוגע לאנליטיקאים – מועיל לשמור על רפרטואר גמיש של התערבויות. אין זה רצוי שהתאוריה שלנו תרסן את התנהגותנו האנליטית עד כדי כך שנמחק את האפשרות של חשיפה עצמית מהרפרטואר שלנו, כפי שפרויד ביקש שנעשה, שכן לפעמים זו יכולה להיות התערבות טיפולית רבת־עוצמה. עם זאת, אל לתאוריה שלנו לגרום לנו לחוש מחויבים באופן כפייתי לחשוף את עצמנו, כמו פרנצי, מתוך האמונה השגויה שזו הצורה היחידה של השתתפות "כנה" ו"אותנטית". כפי שנדון בפרק 5, אינטימיות דורשת הן אוטונומיה והן קשר. תאוריה **אינה** צריכה להגביל את אפשרויות הבחירה שלנו; היא אמורה לסייע לנו להבין, לפחות בדיעבד, כיצד ומדוע אנו מעדיפים אפשרות אחת על פני אפשרות אחרת.

להכיר, ושיכירו אותי

הקשר הפסיכואנליטי הוא פרדוקסלי מיסודו: המטופל והאנליטיקאי מעורבים בו בזמן הן בקשר אישי, אינטימי וספונטני ביותר, והן בקשר מקצועי, מאופק וטכני. הוא דורש מעורבות כנה ואותנטית בין שני אנשים, אך בה בעת – כמו ביחסי אפוטרופסות – דורש התמקדות בחוויית המטופל, בשונה מתשומת הלב המוקדשת לחוויית האנליטיקאי; ומצריך הכרה מתמדת באי־השוויון בחלוקת הכוח והאחריות בין המטופל לאנליטיקאי. ניסיתי ללכוד מתח דיאלקטי זה על ידי איזון חקירת ההדדיות עם הכרה בכך שאי אפשר להימנע מא־סימטריה.

הופמן (Hoffman, 1994) מתאר את התהליך הטיפולי במונחים של חשיבה דיאלקטית. הוא מתמקד בתנועה בין עמדה מרוחקת, מתבוננת ופרשנית יותר מצד האנליטיקאי, לבין מעורבות אישית יותר עם המטופל. הוא מאפיין את התהליך כתנועה דיאלקטית או מתח דיאלקטי בין משמעת פסיכואנליטית להשתתפות מתבוננת. אולם הדיכוטומיה בין האישי והטכני היא בעייתית אם לוקחים אותה רחוק מדי. לא כל קל לפסוק מתי משהו נעשה מטעמים אישיים או מקצועיים; לאמִתו של דבר, המגמה בחשיבה הפסיכואנליטית כיום נוטה לכיוון הטענה כי הטכני מושפע תמיד מהאישי. הטכניקה הפסיכואנליטית, כפי שטוען רניק (Renik, 1993a), היא תמיד סובייקטיבית במידה שאינה ניתנת לצמצום.

כאשר למשל אנליטיקאי חש היסוס מסוים לומר משהו למטופל, האם זו תגובה אישית או שמא מקצועית? האם זהו היבט של הטכניקה הפסיכואנליטית השייך לקטגוריה של טאקט ותזמון, או שזוהי תגובה אמפתית ספונטנית לרגישויות הזולת מתוך מעורבות אישית? אין ספק שהיא כל אלה. הפמיניזם

לימד אותנו כי האישי הוא פוליטי; ואני הייתי אומר כי אצל פסיכואנליטיקאים **האישי הוא טכני והטכני הוא אישי**. התאוריה שלנו העוסקת בטכניקה הטיפולית אינה יכולה לקבוע מתי, היכן, כיצד או מה על האנליטיקאי לחשוף, בלי להביא בחשבון את משמעות החשיפה העצמית עבור האנליטיקאי האינדיבידואלי. משמעויות החשיפה העצמית ותוצאותיה משתנות בהכרח מאנליטיקאי לאנליטיקאי, בהתאם למידת הנוחות האישית של כל אנליטיקאי ואנליטיקאי עם היותו נראה ומוכר. כפי שעלה בדיון בפרק 6, כללי הטכניקה של פרויד לא היו יכולים להתאים לאנליטיקאי עם מזג כשל פרנצי; בדיוק כשם שגישתו הרגשית של פרנצי, עם הדגש שלה על הדדיות, לא היתה מתאימה לעולם לאנליטיקאי בעל אישיות כשל פרויד.

בדיוק כפי שילדים בוחנים ולומדים את אישיות הוריהם, לומדים המטופלים שלנו את אישיותנו. ילדים חותרים ליצור קשר עם הורים, ומטופלים עם אנליטיקאים, באמצעות חיפוש מגע עם עולמו הפנימי של האחר. יש להם מוטיבציה רבת־עוצמה לחדור לתוך מרכז העצמיות של הוריהם ושל האנליטיקאים שלהם. הלך רוח אחד מחפש, באופן בלתי נמנע, אַחַר הלך רוח אַחַר; זהו אספקט אחד של מה שתואר כאינטרסובייקטיביות (ראו פרק 3). אולם ידוע לנו גם שאנשים מסתייגים בצדק מחדירה כזו לתוך לב לִבו של העצמי שלהם. מבוגרים, ילדים, מטופלים, הורים ואנליטיקאים – לכולם יש צורך חזק להגן על היבטים מסוימים של עצמם, שצריכים להישאר פרטיים ושמורים. לכל אחד מאִתנו יש תשוקה יסודית וטבעית למגע עם האחר (דחף לחיפוש אחר אובייקט, למי שאוהב שפה זו), הכולל שני היבטים מובחנים: התשוקה להכיר את האחר, והתשוקה שהאחר יכיר אותי. במונחים קלאסיים, תשוקות אלה מבוטאות פעמים רבות בשני הדחפים המשלימים, סקופטופיליה [מציצנות] ואקסהיביציוניזם, ועלולות גם לעבור רדוקציה לדחפים אלה. אני מדגיש את המשאלה להיחשף בפני האחר, כמו גם את הכמיהה למצוא את תמציתו של האחר. במשפחות מסוימות, משאלה זו יכולה לקבל ביטוי קונקרטי בפנטזיות או בהתנהגויות של מציצנות או של אקסהיביציוניזם מיני (Mitchell, 1988a).

נוסף על שתי משאלות משלימות אלה – להכיר, ושיכירו אותי – יש מערכת מנוגדת של משאלות וצרכים. קיים גם רצון עז להימנע ממגע עם האחר, להיות חבוי ומוגן, להיעזב לנפשי. אם ניתן למצוא עדות לכך שתינוקות נעים לעבר אובייקטים בימים הראשונים לחייהם, ניתן גם למצוא עדות להתרחקותם מאובייקטים באותם ימים. ויניקוט (1963) פיתח את התמה של קונפליקט זה והבחין בין "נסיגה פתולוגית לבין תקשורת־עצמית מרכזית מהסוג הבריא" (עמ' 246). הוא כתב: "אף שאנשים בריאים מתַקשרים ונהנים לתקשר, נכונה באותה

מידה גם העובדה האחרת: **שכל יחיד הוא ישות מבודדת, לעד לא־מתקשר, לעד בלתי־יידוע, למעשה לא־נמצא** [unfound]" (עמ' 244, הדגשה במקור). ויניקוט אפיין שתי מגמות: הצורך ליצור קשר, ולעומתו הצורך הדחוף יותר לא להימצא. מדבריו של ויניקוט משתמע כי העצמי משחק במשחק מחבואים נצחי עם הזולת. מתוך פרספקטיבה זו, התנגדות איננה רק הצד השלילי של המשאלה לבטא משהו, אלא הופכת גם לצד החיובי של משאלת העצמי להישאר חמקמק, להגן על האוטונומיה שלו (המשגה שהתחקינו בפרק 6 אחר מקורותיה בעבודתו של אוטו ראנק). נראה כי קיימת משיכה טבעית לשני הכיוונים, לעבר אחרים ומהם והלאה. גם כאן אנו יכולים לחלק נטייה זו לשניים: המשאלה להתחבא, להתגונן על ידי אי־היחשפות לאחר, והמשאלה המשלימה להימנע מידיעת האחר, להימנע ממגע עם עולמו הפנימי של האחר. אנלוגיה מינית (או מטפורה מינית) לכך יפולה להיות המשאלה לחדור אל תוך האחר והמשאלה שהאחר יחדור אל תוכנו, אל מול המשאלה להימנע מחדירה על ידי האחר והפחד מחדירה אל תוך האחר, או ההימנעות מכך.

אם להחיל רעיון זה על התהליך האנליטי, יש לפנינו שני אנשים, אנליטיקאי ומטופל, ולכל אחד מהם שתי מערכות של תשוקות משלימות ומנוגדות אלה. כל אחד מהם, המטופל והאנליטיקאי, רוצה שיכירו אותו ורוצה להתחבא, רוצה להכיר את האחר ורוצה להימנע מידיעת האחר. הן למטופל והן לאנליטיקאי יש מוטיבציות להתבודדות ולקשר, לאוטונומיה ולהדדיות, לביטוי יוזמה [agency] ולאחווה. אולם המצב האנליטי המסורתי מפצל זוגות אלה בצורה א־סימטרית. האנליטיקאי אמור להכיר את האחר בשעה שהאחר לא יכיר אותו, ואילו המטופל אמור להיות מוּכָּר על ידי האחר אך לא להכיר את האחר. המטופל על הספה אמור להיות נראה אך לא לראות, נחדר אך לא חודר; האנליטיקאי מצוי מחוץ לשדה הראייה, רואה ומכיר במטופל את מה שהמטופל עצמו אינו יכול לראות או להכיר, אולם נותר בלתי נראה, בלתי מוּכָּר, אנונימי ובלתי חדיר.

ואילו מפרספקטיבה התייחסותית ניתן לראות כל היבט בהתנהגות המטופל והאנליטיקאי כפשרה בין המניעים המנוגדים שתיארתי זה עתה (זוהי אחת הדרכים החשובות שבהן התאוריה ההתייחסותית היא תאוריה של קונפליקט, כפי שנדון בפרק 2). המטופל והאנליטיקאי נתפסים כמי שמנהלים משא ומתן תמידי בין צורכיהם הקונפליקטואליים ההדדיים לאינטימיות ולבידוד (Pizer, 1992). כל אסוציאציה וכל פירוש מגלים וגם מסתירים; כל אחד מהם הוא ניסיון ליצור מגע ולהימנע ממגע, להכיר את האחר ולהימנע מידיעת האחר. גרינברג (Greenberg, 1995), שעשה הבחנה דומה, טוען: "אם נכון הדבר שכל דבר שאנו עושים מגלה משהו, כי אז נכון לא פחות שכל דבר שאנו עושים מסתיר משהו

אחר" (עמ' 195). לאור הבחנות אלו, ברצוני להבהיר כי כאשר כתבתי קודם לכן כי "חשיפה עצמית **אינה** אפשרות העומדת בפני האנליטיקאי; היא בלתי נמנעת", תיארתי את המצב הקיים ולא את המצב הרצוי. גם אנונימיות יחסית **אינה** אפשרות, אלא כורח בלתי נמנע, היות שאנו תמיד מסתירים, גם כאשר אנו חושפים! אם אין מנוס מגילוי היבטים מעצמנו, בה במידה אין מנוס מהסתרת היבטים מעצמנו.

נראה לי כי הבנת מערך זה של תשוקות משלימות ומנוגדות יכולה להועיל כשאנו באים לבחון את הרילמות שמציגות החשיפות העצמיות המכוונות או התכליתיות של האנליטיקאי. בקונפליקטים רב־שכבתיים אלה, נוכל להבחין שגילוי מכוון של האנליטיקאי החושף משהו בפני המטופל יפעיל קונפליקטים משלימים הן במטופל והן באנליטיקאי, שכן כל אחד מהם נאבק שיכירו אותו ושלא יכירו אותו, ומתמודד עם תשוקות להכיר את הזולת ולא להכירו. לא ניתן להמליץ על טכניקה פסיכואנליטית במנותק מאישיותו האינדיבידואלית של האנליטיקאי. יש אנליטיקאים שאופיים והקונפליקטים הרינמיים שלהם בנושאים אלה של להכיר ולאפשר להכיר אותך עשויים לגרום להם לאפשר פחות חשיפה מכוונת, כלומר לעבוד בדרך אנונימית ומסורתית יותר, גם אם הם מכירים בכך שגילויים עצמיים מתרחשים ללא הרף באופן לא־מודע ולא־מכוון. יש גם אנליטיקאים אחרים, שאֶפיוני אישיותם מאפשרים להם לחוש יותר בנוח עם שימוש משוחרר יותר בעצמם ועם ניצול פעיל יותר של חשיפות עצמיות. הוסיפו על שונות זו בין האנליטיקאים את העובדה שגם המטופלים שונים זה מזה ביחס לקונפליקטים אלה, והמצב הופך מורכב לאין שיעור. עצם הביטוי חשיפה עצמית מטעה, שכן משתמע ממנו עצמי לכיד הבוחר לחשוף את מרכז הקיום שלו. אולם בדיון שלי בנושא האינטרסובייקטיביות (פרק 3) טענתי כי באופן בלתי נמנע אינטרסובייקטיביות מתייחסת למשחק הגומלין בין עצמיים מרובים לאחרים מרובים. מתוך פרספקטיבה זו, כאשר האנליטיקאי חושף את עצמו יש לשאול מי מבין העצמיים המרובים של האנליטיקאי חושף, ולפני מי מבין העצמיים המרובים של המטופל נחשף הדבר?

חשיפה עצמית וסמכות האנליטיקאי

חשיפה עצמית תכליתית מצד האנליטיקאי, בדיוק כמו אסוציאציה של המטופל, יש לבחון בהתייחס למה שהיא מבטאת, ולמה שהיא מסווה. זוהי נקודה שקל להחמיץ. גרינברג (Greenberg, 1995) קובע: "גם המטופל וגם האנליטיקאי סבורים כי כאשר האנליטיקאי חולק מחשבה אישית או תחושה אישית הוא נותן

משהו, והם עושים יד אחת בהתעלמותם ממה שנמנע ולא ניתן" (עמ' 196). מאחר שאנליטיקאים נתפסים תמיד כבעלי מידה מסוימת של סמכות במצב הקליני, כאשר הם מגלים למטופלים משהו על עצמם יש ציפייה שהדבר יתקבל כאמת (Hoffman, 1983). מסיבה זו, סכנה אפשרית של חשיפה עצמית מצד האנליטיקאי היא מניעת המשך החקירה, משום שהחשיפה מתקבלת כפשוטה – כאמת המוסמכת של האנליטיקאי.

תוך כדי התרחקות רדיקלית מהטכניקה הפרוידיאנית המסורתית, ותוך הרחבת עמדתו הבינאישית המוקדמת של ארווין סינגר, טוען רניק (Renik, 1995) כי לא זו בלבד שעלינו להתעלם מעקרון האנונימיות האנליטית, אלא עלינו אף לסתור אותו באופן פעיל ותקיף. לטענתו, על ידי הימנעות מחשיפה עצמית, על ידי שימור העמדה האנונימית הקלאסית, אנו מזמינים ממטופלינו אידאליזציה ונענים לה, גם אם אנו מתיימרים להיות מחויבים לניתוח אנליטי של הארה זו. רניק ממליץ כי במקום לחתור לאנונימיות ועמימות אישית, מוטב שהאנליטיקאים יאפשרו למטופלים נגישות מרבית, ככל שניתן, למחשבה שלהם על טבע השתתפותם עם המטופלים. הוא סבור שנמנענו מלעשות זאת משום שאנו מעוניינים לשמר את עמדתנו כבעלי הסמכות, בעוד אנו מוסיפים לטעון כי הפסיכואנליזה מתנזרת מהשפעה סוגסטיבית מעין זו על מטופלים.

מנוגדת לחלוטין היא עמדתו הבינאישית של לורנס אפסטיין (Epstein, 1995), ולפיה אל לו לאנליטיקאי "לפזר את הערפל" בנוגע לעצמו למטופליו, אלא רצוי שיבסס את התנאים המיטביים שהמטופל יוכל להשיג בהם דה־מיסטיפקציה כזו בכוחות עצמו. אפסטיין מודאג שמא בכותרת של כינון הסובייקטיביות שלנו נכפה את הסובייקטיביות שלנו על המטופל, במקום לאפשר למטופלים לגלות ולחשוף את הסובייקטיביות שלנו באופן ובעיתוי שמתאימים להם. מהערתו של אפסטיין משתמע כי העמימות של האנליטיקאי יכולה לשרת מטרה מועילה. כפיית הסובייקטיביות של האנליטיקאי בשלב מוקדם מדי של האנליזה עלולה להגביל את ניסיונות המטופלים לחקור את הטווח המלא של תפיסותיהם ביחס לאנליטיקאי. זהו אחד מאותות הזמן, שאנליטיקאי פרוידיאני ידוע טוען **לטובת** חשיפה עצמית, ואנליטיקאי בינאישי בעל מוניטין ממליץ על זהירות.

עיינו בדוגמה של רניק (Renik, 1995):

> למטופל היה הרושם שנהגתי בו בעדינות ובזהירות רבה בשעה הקודמת, משום שחששתי לפגוע בו. בתגובה אמרתי שאינני מודע לדאגה מיוחדת מצדי, ועל כן – לפחות מנקודת המבט שלי – יש למטופל סיבות משלו לדמיין שהוא כה שברירי בעיני. להרגשתי, מועיל שאבהיר את תפיסתי

> ביחס למצבי הרגשי במהלך השעה הנדונה, שכן השערתי כי יש למטופל מניע נסתר לחוות אותי כעדין וכזהיר מבוססת בחלקה על תפיסה זו (עמ' 485).

למרות אהדתי לשאיפתו של רניק לכונן את החשיפה העצמית כהתערבות אנליטית לגיטימית, בעיני דוגמה זו היא בעייתית ביותר. מקרה זה ממחיש לצערי את הסכנה כי נקודת הראות של האנליטיקאי על השתתפותו עם המטופל תתקבל על ידי האנליטיקאי והמטופל גם יחד כאמת המוסמכת ביחס לטבעה של האינטראקציה ביניהם. רניק מצהיר כי הוא מציג את דעתו למטופל אך ורק כתפיסה שלו ביחס לחווייתו הרגשית. אף על פי כן, רניק מעודד את המטופל להתבסס על תפיסתו העצמית של האנליטיקאי, ולהפנות את תשומת לִבו בחזרה לעצמו ול"מניעיו הנסתרים" לעוות את תפיסת האנליטיקאי. הדבר עלול **לחסום** את המשך חקירת הסובייקטיביות של האנליטיקאי על ידי המטופל. בעצם המאמץ להשיג דה־מיסטיפיקציה ודה־אידאליזציה של האנליטיקאי, מבסס רניק בסופו של דבר את סמכותו כשופט בנוגע לאיכות השתתפותו עם המטופל, גם אם באופן רשמי הוא מצהיר שאין הוא הבורר ביחס לאמת.

במקום לומר למטופל: "אינני מבחין שאני חש דאגת יתר לגבי שבריריותך, כך שבוודאי יש לך סיבות אחרות לחשוב שאני כה מודאג", אני ממליץ לומר: "אינני מבחין שאני חש דאגת יתר לגבי שבריריותך, אך נראה שאתה חושב כך. מה אני עושה שיוצר אצלך רושם זה? אולי אתה קולט משהו שלא שמתי אליו לב".

ניתוח ההשפעה של גילוי עצמי כלשהו, מכוון או לא־מכוון, נעשה מורכב משום שיש סיכוי סביר שתפיסות המטופל את האנליטיקאי יהיו לא־מודעות. כחלק מההגדרה המסורתית של תפקידנו – להפוך את הלא־מודע למודע – מוטלת עלינו מידה מסוימת של אחריות לסייע למטופלים לדעת במודע דברים לגבינו שהבחינו בהם באופן לא־מודע. אין זה פשוט לסייע למטופל להכיר בתפיסותיו הלא־מודעות ביחס לאנליטיקאי, שכן אנו עצמנו יכולים להיות מודעים או לא־מודעים לאותם דברים. למעשה, אחת הסיבות שהמטופל עלול להשאיר דברים אלה לא־מודעים היא פחד שמא ביטויים יעורר חרדה באנליטיקאי. על כן כפי שהצליחו אולי לעשות עם הוריהם בילדותם, וכפי שהם מצליחים אולי לעשות בתחומים אחרים בחייהם, מטופלים אינם מרשים לעצמם לדעת מה שהם יודעים עלינו משום שידיעתם תגרום לנו להיות חרדים מדי. זוהי תמצית השקפתו של סליבן (Sullivan, 1953) ביחס למקורות אי־הקשב הסלקטיבי [selective inattention].

אך כיצד אוכל אני, האנליטיקאי, לסייע למטופל להיות מודע למשהו בנוגע אלַי, בשעה שאני עצמי עדיין אינני מודע למה שהמטופל יודע, יהיה אשר יהיה? בפרק 3 הצעתי שעל האנליטיקאי לפתח טכניקה לעקוב אחר הדרך שהמטופל תופס את הקשר האנליטי, או מה שכיניתי חוויית המטופל את הסובייקטיביות של האנליטיקאי. היתה זו הרחבה של הצעתו של ראקר (1968) כי אחת הדרכים הטובות ביותר לחקירת ההעברה של המטופל היא להתחקות אחר הפנטזיות של המטופל על ההעברה־הנגדית של האנליטיקאי. אולם אם תברר בהתמדה כיצד חווה המטופל את הסובייקטיביות שלך, עשוי המטופל לבקש ממך עד מהרה לשמוע יותר על הסובייקטיביות שלך ישירות. התמקדות בחוויית המטופל ביחס לסובייקטיביות של האנליטיקאי יכולה להעיר מרבצם קונפליקטים במטופל ובך, בנושאים של להכיר ושיכירו אותי. קל יותר לא לגלות הרבה למטופל כאשר אינך ממקד את העדשה האנליטית על אזור חקירה זה, אך ברגע שאתה מתמקד בו אפשר שהמטופל לא יוכל לשאת מצב שאיננו מקבל בו שום תגובה, והימנעות מתשובות כלשהן עלולה להיחוות כעינוי. נוסף על כך, פעולת החקירה של תפיסות המטופל ביחס לסובייקטיביות שלך עשויה לחשוף לא מעט עליך. חלק ממה שיודעים מטופלים על האנליטיקאים שלהם, ואולי אינם יודעים שהם יודעים, היא ההכרה בקונפליקטים של האנליטיקאי ביחס לאפשרות שיכירו אותו.

גילוי עצמי אינו טכניקה. אין זה גימיק התייחסותי חדש. זו פשוט דרך אחת מני רבות להיות עם המטופל שסוף־סוף איננה בבחינת טאבו; זו אופציה טכנית ואישית – אפשרות שתמיד מגלה ומסתירה, שהופכת את המטופל והאנליטיקאי הן נגישים יותר זה לזה והן נגישים פחות, ולפיכך אפשרות ששני המשתתפים צריכים תמיד לבחון אותה ולשקול אותה. אל לנו פשוט להפוך על פיה את הטכניקה המקובלת, ולהציב את עקרון החשיפה העצמית במקום עקרון האנונימיות, כפי שמציע רניק (Renik, 1995). היפוך עקרונות מסוג זה אינו מותיר בידינו די גמישות טכנית. אל לנו לחזור על שגיאתו של פרנצי, שכתגובת נגד לאנונימיות של פרויד פנה לקיצוניות השנייה של חשיפה עצמית כטכניקה שגרתית. מוטב לראות בחשיפה עצמית אופציה טכנית ואישית אחת מני רבות, שיש להשתמש בה תוך שיקול דעת קליני והתבוננות משותפת.

ככל שהגילוי העצמי משקף ניסיון מכוון להיות האובייקט הטוב, כך הוא הופך טכני מדי ומאבד משהו מאותם יתרונות הטמונים בספונטניות ובאותנטיות שבו. כפי שכתב ברומברג (Bromberg, 1994) על חשיפה עצמית:

> תועלתה לתהליך האנליטי מבוססת על אמינותה כמעשה אנושי אותנטי,

> בייחוד במידה שהאנליטיקאי משוחרר מלחץ פנימי (מודע או לא־מודע) להוכיח את כנותו, או את היותו ראוי לאמון, כתכסיס טכני המיועד להפיג את חוסר האמון של המטופל. החשיפה העצמית של האנליטיקאי חייבת להיות מה שכינה סימינגטון (Symington, 1983) "אקט של חירות", שהאנליטיקאי חש בו בנוח לשמור לעצמו את זכותו לא לחשוף את עצמו, ואם הוא בוחר לחשוף – לעמוד על זכותו לפרטיות ולהציב את גבולותיו (עמ' 540).

בעיני, חירות טכנית ואישית זו של האנליטיקאי היא העמדה המועילה ביותר לעבוד ממנה; כשאנו שומרים את האפשרויות שבפנינו פתוחות – לחלוק או לשמור לעצמנו את חוויותינו – אנו מבטיחים מידה אופטימלית של א־סימטריה. כפי שראינו בפרק 6, חירות זו היא בדיוק מה שפרנצי איבד בניסוייו הקליניים באנליזה הדדית.

גוונים שונים של חשיפה עצמית

קשה להכליל ביחס לחשיפה עצמית, שכן מונח זה מתייחס לפעילויות רבות ושונות. הרשימה הבאה רחוקה מלהיות ממצה, אך היא ממחישה עד כמה רחב טווח הפעילויות הנכללות תחת הכותרת חשיפה עצמית:

(1) סוג אחד של חשיפה עצמית נוגע למחשבות האנליטיקאי כשהוא במחיצת המטופל. דוגמה פשוטה לסוג זה היא שיתוף המטופל באסוציאציות שעולות באנליטיקאי ביחס לדימוי מסוים בחלום שהמטופל סיפר.

(2) תיתכן חשיפה עצמית של תגובתו הרגשית המיידית של האנליטיקאי כשהוא במחיצת המטופל; למשל, לומר או להראות למטופל שהאנליטיקאי חווה עצב או רוגז.

(3) יש חשיפות עצמיות הכרוכות בשיתוף המטופל במחשבות ובתגובות הרגשיות הנוגעות לאינטראקציה בין המטופל לאנליטיקאי; למשל, כאשר מטופל מבחין בכך שהאנליטיקאי היה קריר ומרוחק יותר בשבוע האחרון, והאנליטיקאי חולק מחשבות על מה שהתרחש ביניהם ועל תחושותיו המודעות, ודן בהשערותיו ביחס למניעים להתנהגותו זו. דוגמה נוספת תהיה לתאר בפני המטופל קונפליקט שמתעורר באנליטיקאי כיצד לגשת לנושא מסוים באנליזה.

(4) חשיפה עצמית מסוג אחר נוגעת למחשבות של האנליטיקאי על המטופל

מחוץ למערך הטיפולי [setting]; למשל, לומר למטופל שחשבת עליו בזמן שקראת כתבה בעיתון הבוקר. דוגמה קיצונית יותר לסוג זה של חשיפה עצמית תהיה שיתוף המטופל בחלום שחלם עליו האנליטיקאי. אני מכנה זאת דוגמה קיצונית משום שהחומר שנחשף עשוי להיות מורכב ורב־משמעי הרבה יותר ממידע אחר שניתן לשתף בו.

(5) תיתכן חשיפה עצמית של הסיבות לתחושות האנליטיקאי, לרבות גורמים התפתחותיים או תכונות אופי שהם מחוץ לאינטראקציה האנליטית העכשווית.

(6) חשיפה עצמית יכולה להתרחש בתגובה לשאלות אובייקטיביות פשוטות של המטופל, כמו מה גילו של האנליטיקאי, מהו מצבו המשפחתי, האם יש לו ילדים, או באיזו מכונית הוא נוהג.

(7) כל אחת מקטגוריות אלה מתייחסת לחשיפה עצמית ישירה ומכוונת, שיש להבחין מכל אותם גילויים עצמיים משתמעים או פחות ישירים המתרחשים ללא הרף באנליזה.

(8) הבחנה נוספת, שהיא מעבר לכל ההבחנות האחרות, היא ההבדל בין שיתוף במחשבה, רגש או חוויה שהאנליטיקאי הקדיש להם כבר מחשבה ועיבוד, לבין שיתוף ספונטני יותר לפני שהיתה לאנליטיקאי הזדמנות לעיבוד (לדיון בנושא זה בהקשר לעבודתה של ארנברג [Ehrenberg, 1992] ראו Burke & Tansey, 1991).

(9) הבחנה אחרת היא אם נידב האנליטיקאי פיסת מידע שיש בה חשיפה עצמית, או שמא גילה משהו רק לאחר שהמטופל העלה את הנושא ושאל את האנליטיקאי שאלה ישירה עליו (מרודה [Maroda, 1991] רואה הבחנה זו כקריטריון החשוב ביותר כדי לקבוע מתי לחשוף תכנים של העברה־נגדית).

(10) אפשר גם להבחין בין סוגי חשיפה עצמית על בסיס התוכן של חוויית האנליטיקאי. למשל, אנו עשויים להבחין בין חשיפה עצמית שיש בה תוכן תוקפני, לעומת חשיפת תוכן מיני, או רגש אחר כלשהי.

ביחס להבחנה האחרונה, דייויס (Davies, 1994) דנה במקרה שבו סיפרה למטופל שהיו לה פנטזיות מיניות לגביו. הדיווח על התערבות שנויה במחלוקת זו עורר חילופי דברים סוערים, וגברד (Gabbard, 1994) טען כי יש להתייחס לחשיפת רגשותיו המיניים של האנליטיקאי כאל קטגוריה בפני עצמה, ואין לגלותם למטופלים בשום מקרה או כמעט בשום מקרה. גם גורקין (Gorkin, 1987) ומרודה (Maroda, 1991), שנוקטים עמדות ליברליות ביחס לחשיפת

רגשות בפני מטופלים, זהירים במיוחד בנוגע לחשיפת העברה־נגדית מינית. בראט (Barratt, 1994), הדן בספר **הקצה האינטימי** של ארנברג (Ehrenberg, 1992), מציין שאף שהיא מרבה לתאר מקרים שבהם שיתפה מטופלים בתגובותיה הרגשיות כלפיהם, אין היא מביאה אף דוגמה אחת שבה היא מגלה למטופל כי הוא מעורר אותה מבחינה מינית. מהבחנה זו הוא מסיק כי לשיטה טיפולית מעין זו "יש הנחות יסוד וגבולות, אך אופי השיטה דורש להניח להם בלי שייחקרו" (עמ' 279). חקירה כזו של ההנחות והגבולות, שהיא ממהות השיטה הטיפולית, היא בדיוק מה שפרק זה חותר להשיג, ולכך חתרו גם מאמרה של דייויס (Davies, 1994) והדיונים שהתעוררו בעקבותיו בהשתתפות בנג'מין (Benjamin, 1994) וגברד (Gabbard, 1994).

מאפיין נוסף המבחין בין סוגים שונים של חשיפה עצמית קשור פחות לתוכן ויותר לאופן שהתרחשה בו החשיפה. יש חשיפות (או פירושים או התערבויות אחרות) הנעשות כך שהן חותמות את הנושא, בשעה שחשיפות אחרות נעשות כך שהן פותחות דיאלוג נוסף. נדמה לי שההבדל כאן נעוץ בשאלה אם הדברים נאמרים באווירה של ודאות וסמכות, או שמא ברוח של חקירה ומשחק. ויניקוט (1954) למשל תבע כידוע להישמר מפני חודרנות האנליטיקאי לתוך הסביבה הפסיכואנליטית. עם זאת, בולאס (1987) מציין כי כמטפל היה לוויניקוט דפוס עבודה המבטא נוכחות אישית ייחודית מאוד [אידיומטית], והוא שיחק עם מטופליו באמצעות שרבוטים [squiggles] מילוליים. בולאס שואל כיצד ניתן ליישב בין ויניקוט התאורטיקן, שדגל בנוכחות שקטה ובלתי חודרנית, לבין ויניקוט הקלינאי האנליטי שכה נוכח כמות שהוא באנליזה. בולאס סבור כי התשובה לכך טמונה בגישתו של ויניקוט ביחס למחשבות שחלק עם מטופלים. הוא התייחס למחשבותיו ולפירושיו כאל

> אובייקטים סובייקטיביים... ולאו דווקא כפְּעֻנּוח פסיכואנליטי רשמי של חיי הלא־מודע של אותו אדם. השפעתה של גישה זו היא מכרעת משום שהפרשנויות שלו נועדו לכך שישחקו בהן – יסובבו אותן [יבעטו בהן], יהרהרו בהן ואפילו יקרעו אותן לגזרים – ולא שיראו בהן גְּרסה של "כזה ראה וקדש" (עמ' 218).

ייתכן שעמדת האנליטיקאי כלפי מחשבותיו, הרגשותיו, האסוציאציות והפירושים שלו חשובה יותר מתוכנם. מה שלא יחשוף האנליטיקאי, גישתו כלפי החשיפה היא שתקבע אם ההתערבות תגרום למטופל להרגיש בטוח או מאוים יותר.

בין הניסיונות הקודמים לסווג מגוון קטגוריות של חשיפה עצמית, אולי ההצעה המשכנעת ביותר הועלתה על ידי סרלס (Searles, 1975), כאשר חלק על אותם אנליטיקאים בינאישיים דוגמת סינגר (Singer, 1968) שדגלו בהפחתה ניכרת באנונימיות של האנליטיקאי. סרלס כתב על עבודתו כמטפל: "בשעה שאני חופשי יחסית בגילוי תחושות ופנטזיות שאני חווה בשעה הטיפולית עצמה, אני מספר למטופלים מעט מאוד על חיי מחוץ לחדר הטיפולים" (עמ' 458). הבחנה זו בין חשיפה הנוגעת למתרחש **תוך כדי הפגישה** לבין חשיפה העוסקת בחייו של האנליטיקאי מחוץ לטיפול הפכה לאחד מגורמי המפתח בליבון השאלה אם לנקוט או לא לנקוט חשיפה עצמית.

בססקו (Basescu, 1987, 1990) טוען כי חשיפת התגובות האישיות למתרחש במצב הטיפולי שייכת לתחום החשיפה העצמית הרלוונטי והחשוב ביותר, שהוא הפחות שנוי במחלוקת. וכטל (Wachtel, 1993) מציין כמה סיבות מדוע סוג זה של גילוי מועיל לתהליך האנליטי, ומדגיש במיוחד ששיתוף המטופל בתגובות כלפיו וכלפי דבריו נותן אישור שמישהו מקשיב, נוכח ומגיב רגשית למטופל. וכטל טוען כי שיתוף המטופל בתגובותיו הרגשיות של המטפל מוכיח למטופל כי היתה לו השפעה רגשית על המטפל – וזה עשוי להיות בדיוק מה שהמטופל זקוק לגלות. חשובה מכול היא טענתו של וכטל כי שיתוף המטופל בתגובות הרגשיות של האנליטיקאי עשוי לקדם הבנה טובה יותר של חוויית המטופל. גילוייו העצמיים של האנליטיקאי יכולים לתרום לכך שהמטופל יגיע להבנה טובה יותר של ההקשר הבינאישי של ההעברה.

וכטל (Wachtel, 1993) מסכים עם אחרים שעודדו את השימוש בחשיפה עצמית כאשר תכניה קשורים ישירות לתהליך האנליטי המִיָדי, אך הוא טוען גם כי עצם ההבחנה בין "פנימי" ל"חיצוני" יכול לקרוס בקלות. לדבריו, גם אם האנליטיקאי מגלה למטופל משהו שנראה לא קשור למתרחש באינטראקציה הטיפולית המִיָדית, עדיין סביר כי במחשבה נוספת יימצא קשר משמעותי כלשהו בין מה שנחשף להתרחשות באותו רגע. כך, גם חומר חיצוני לאנליזה עשוי לתרום באופן מועיל.

שקלו לדוגמה את המלצותיה של קארן מרודה בספרה **כוחה של ההעברה־הנגדית** (Maroda, 1991). זוהי עבודה נפלאה ובמובנים מסוימים פורצת דרך, שבה טוענת המחברת בתוקף כי יש לשנות את הפרקטיקה הטיפולית כך שהאנליטיקאי יהיה חופשי יותר להשתמש בהיענות רגשית מִיָדית. קריאתה של מרודה לשימוש טיפולי בחשיפה עצמית היא השקולה, השיטתית והיסודית ביותר עד כה. היא מציעה שאנליטיקאים יחלקו תחילה רק את חווייתם הרגשית המִיָדית, ורק בהמשך האנליזה יגלו את המקורות של תחושות אלה בחייהם

האישיים. במילים אחרות, ראשית היא דוגלת בחשיפת ההעברה־הנגדית של האנליטיקאי; שנית, בניתוח השפעת חשיפה זו על תבנית ההעברה/העברה־נגדית; ולבסוף, לרוב רק בשלב הסופי של האנליזה, בניתוח אנליטי מכוון בידי האנליטיקאי של ההעברה־הנגדית במונחים של מקורותיה ההתפתחותיים והאישיותיים. הקו המנחה שלה הוא שעל האנליטיקאי לחשוף את ההעברה־הנגדית שלו רק לבקשת המטופל, או לאחר התייעצות זהירה עִמו ובאישורו. אני סבור כי קווים מנחים אלה הם שימושיים ביותר מבחינה טיפולית.

עם זאת, אני חושש שמא מה שנועד לשמש קווים מנחים ייתפס כחוקים, וששימוש מוטעה זה עלול לסכל חקירה טיפולית מועילה נוספת. למשל, עבדתי עם מטופלים שלתחושתי הפיקו תועלת רבה מנכונותי לגלות בשלב מוקדם מאוד של האנליזה משהו פרטי על עצמי, לרבות מקורותיה של תגובה מסוימת בחיי הפרטיים. יתר על כן, מהבחנתה של מרודה משתמע כי המטופל ימתין עד לשלב הסופי של האנליזה לפני שיחקור את האנליטיקאי על קושי בהעברה־הנגדית. ניסיוני שלי מלמדני, אולי בשל התמקדותי בחוויית המטופל ביחס לסובייקטיביות של האנליטיקאי, כי מטופלים מסוימים ילחצו עלי לגלות זאת בפניהם מוקדם יותר בעבודה האנליטית. נוסף על כך, מרודה מציינת כי בשלבים המאוחרים של האנליזה עשוי האנליטיקאי לחשוף יותר מההעברה־הנגדית שלו בפני המטופל; אולם תשומת הלב שלי מכוונת יותר – בעקבות פרנצי – לפירושים המרומזים שמבטא המטופל ביחס להיבטים בהעברה־הנגדית שאני עלול לא להיות מודע להם. במילים אחרות, נראה כי מרודה עסוקה יותר באפשרות שאנליטיקאים יחשפו את מה שהם יודעים על ההעברה־הנגדית שלהם, ואילו אני מדגיש יותר כיצד מסייעים מטופלים לאנליטיקאים שלהם לזהות היבטים של השתתפותם שלא היו מודעים להם. שני התהליכים פועלים כמובן יחדיו.

מרודה גם ממליצה לעשות שימוש בגילויים עצמיים רק לאחר שהאנליטיקאי ניסח לעצמו ועיבד את השלכות החשיפה על המטופל. אני סבור כי גם זהו קו מנחה מועיל, בייחוד בעת הדרכת אנליטיקאים בשלב הכשרתם, אך נטייתי היא להסכים עם ארנברג (Ehrenberg, 1992) כי לעתים מוטב להגיב בצורה ספונטנית ומִיָדית יותר, מבלי לעבד קודם לכן את התגובה, ואז לבחון עם המטופל מה היתה השפעת התגובה על התהליך האנליטי.

כפי שניתן להסיק אפילו משאלות מעטות אלה שאני מעלה ביחס לקווים המנחים של מרודה, ייתכן שהדבר החשוב ביותר שניתן לומר על חשיפה עצמית הוא כי כאשר פותחים נושא זה לדיון כסוגיה טיפולית חשובה, מתברר שיש בהחלט הרבה במה לדון. כאשר האפשרות של חשיפה עצמית נשללת מראש כגורמת לטשטוש הגבולות המקצועיים, או שרואים בה פגיעה במסגרת

האנליטית, כי אז אי אפשר לשקול כראוי אף אחת מן ההבחנות או מהשאלות הטכניות האלה. אף שיש לי הסתייגויות מסוימות, למשל בנוגע לחלק מהקווים המנחים של מרודה, אני סבור כי יש לנו בכל זאת הרבה מן המשותף; שנינו מאמינים בהדדיות המהותית של התהליך הפסיכואנליטי; שנינו מעריכים את התגובתיות הרגשית של האנליטיקאי, ושנינו מכירים בתועלת הטמונה לפחות בצורות מסוימות של חשיפה עצמית. חשוב מכך, אף שמרודה, גורקין, ארנברג, טנזי וברק, גולדסטיין, בולאס, גרינברג, מיטשל, רניק ווכטל ניגשים לנושא בדרכים שונות במקצת, כולם מתלבטים כיצד להתמודד עם חשיפה עצמית באופן שיקדם את התהליך האנליטי, יגן על מטופלים מפני ניצול, וישמר את המרחב האנליטי כמקום שבראש ובראשונה משרת את צרכיו הטיפוליים של המטופל. אני סבור כי ההחלטה במה כדאי לשתף מטופלים מתוך זרם האסוציאציות והרגשות האינסופי היא בחירה אישית, בחירה שמשתנה מאנליטיקאי לאנליטיקאי, ממטופל למטופל ומרגע לרגע בכל אנליזה. אני סבור כי ניסיונות סיווג אלו הם צעד חיוני ראשון בקידום חקירה וניסויים קליניים.

התנגדויות לחשיפה עצמית כמסיחה את הדעת מחוויית המטופל

אחת ההתנגדויות השכיחות ביותר לגילוי עצמי שמעלים אנליטיקאים היא שכל ביטוי של הסובייקטיביות של האנליטיקאי מסיח את הדעת מן ההתמקדות הבלבדית הנדרשת בחוויית המטופל. עמיתים מצביעים על כך שהסטת תשומת הלב מן המטופל נובעת כנראה מן הצורך של האנליטיקאי בתשומת לב, ושהתרחשותה במצב האנליטי היא מימוש מחדש בפעולה של הבעיה שמטופלים רבים סבלו ממנה כילדים – גם הוריהם כפו עליהם להתאים את עצמם לצורכיהם (של ההורים). על כן אם האנליטיקאי מעתיק את מוקד תשומת הלב מחוויית המטופל לזו שלו, הוא חודר או מפריע למה שאמור להיות המרחב הפוטנציאלי של המטופל; במקרה הטוב, התוצאה היא ציות כנוע מצד העצמי הכוזב. טיעון זה מתחזק עוד יותר כשאנליטיקאים מציינים כי מטופלינו סובלים לא פעם מפגיעות נרקיסיסטית, יחסי האובייקט שלהם אינם מפותחים דיים וחסרה להם עדיין רמת התחכום בקשר הנדרשת להדדיות או לאינטרסובייקטיביות אמִתית. על כן נחוצה זהירות עצומה בנוגע לחשיפה עצמית.

מובן שנסכים כולנו, מטעמים מקצועיים ואתיים, שכאשר אנו עושים אנליזה מטרתנו היא לשרת את האינטרסים ארוכי הטווח של מטופלינו. אולם יש מקום לחילוקי דעות לגיטימיים עד כמה מעורבותו וחשיפתו האישית של האנליטיקאי עשויות לקדם את האינטרסים ארוכי הטווח של המטופל. יש

להעניק למטופלים מרחב שיאפשר להם להשתמש באנליזה בדרכים שנחוצות להם, אך בסוגיה החשובה ביותר יש עמימות: מהי הענקת מרחב מרבי למטופל? ראשית, גם אם נקבל את ההנחה שחשיפה עצמית מוגזמת מצד האנליטיקאי עלולה להיות הרסנית, עדיין נותר מקום למידה של חשיפה עצמית שתוכל להיות קונסטרוקטיבית. שנית, יש מגבלות לטיעון התפתחותי שהובא זה עתה, המדגיש את סכנת ההרסנות כאשר הורים תובעים כי ילדיהם יענו על צורכי ההורים. וכטל (Wachtel, 1993) טוען:

> גידול ילדים ללא אנוכיות כלשהי, כשצורכי ההורה ורגשותיו נותרים מחוץ לתמונה, אינו אפשרי ואף אינו רצוי. ילדים צריכים **להכיר** את הוריהם ממש כפי שהם זקוקים לכך שהוריהם יכירו אותם. הבסיס ליכולת לאינטימיות ולזהות אישית מחייב תחושה של ההורה כיצור חווה אחר, בעל יוזמה פעילה ומשאלות משל עצמו (עמ' 213).

אזדרז להוסיף עם זאת כי יש לילדים גם צורך **לא** להכיר היבטים בחיי הוריהם, כמו גם צורך שהוריהם לא יכירו היבטים שלהם. אנו יכולים להקיש ממודל התפתחותי זה כי באופן דומה לא זו בלבד שלמטופלים יש צורך שהאנליטיקאים שלהם יבינו ויכירו אותם, אלא הם צריכים גם להכיר ולהבין לא מעט ביחס לאופיים וליחסיהם הבינאישיים של האנליטיקאים שלהם. בה בעת זקוקים מטופלים גם שיתאפשר להם **לא** להכיר היבטים של האנליטיקאים שלהם, וזקוקים גם למרחב פרטי שהאנליטיקאי אינו מכיר. ניסיון להתמודד עם מורכבות זו מתבטא בהמלצתה הטכנית של מרודה (Maroda, 1991) שעל האנליטיקאי לתת למטופל להוביל אותו, ולשקול חשיפה עצמית רק לאחר שבדק עם המטופל ישירות אם הוא מעוניין לדעת את תגובת האנליטיקאי. אף שאני מסכים עם המלצה זו באופן כללי, כמו עם יתר הקווים המנחים, אפשר שיהיו יוצאים מן הכלל; אפילו מרודה סבורה כי השימוש של מטופל בהזדהות השלכתית עשוי לבטא קריאה סמויה לאנליטיקאי לחשוף את עצמו. לעתים יכול האנליטיקאי להחליט בצדק כי יש לעמת את המטופל עם תגובות האנליטיקאי, גם בשעה שהמטופל מעדיף ש"ירפו ממנו". שיקול הדעת הטיפולי במקרה זה יכול להיות מסובך, אך זוהי החלטה טיפולית חשובה, ו"הבחירה הנכונה" עשויה להיות שונה בהתאם לגורמים הקשורים במטופל ובשלב שהטיפול נמצא בו, ולהשתנות מאנליטיקאי לאנליטיקאי. יתר על כן, אמירות של מטופלים שהם רוצים או אינם רוצים לדעת משהו על האנליטיקאי שלהם עשויות בהחלט להתגלות לאחר בחינתן כאמירות שלאו דווקא משקפות במלואם את רצונותיהם.

עיינו ברוגמה הבאה, שהציגו גברד ווילקינסון (Gabbard & Wilkinson, 1994) כאשר דנו בשימוש בהעברה־נגדית עם מטופלים גבוליים. נ׳ נסערת ומטילה אימה על המטפל שלה, ד״ר מ׳, כשהיא מאיימת שתהרוס את חדר הטיפולים שלו או שתתאבד. היא זועמת על כך שהטיפול הוא חסר תועלת והמטפל שלה חסר ערך. בסופו של דבר אומר לה ד״ר מ׳: ״עכשיו אני מרגיש זוועה, אני חושש. נראה לי שאת גורמת לי להרגיש את הזוועה שבתוכך״ (עמ׳ 147). על פי הדיווח, בעקבות חשיפה עצמית זו נרגעת המטופלת וחשה לראשונה עצב של ממש. לפי המחברים, כאשר שיתף ד״ר מ׳ את המטופלת בתגובתו הרגשית, הוא זיהה ושינה את האינטראקציה של ההעברה/העברה־נגדית שיצרו במשותף. באמצעות שימוש במה שגברד ווילקינסון מכנים ״כנות טיפולית״ (עמ׳ 143), וחשיפת חוסר האונים והזעם המייסרים אותו, שיקם ד״ר מ׳ את העצמי שלו כישות מובחנת מנ׳, ובכך קידם את העבודה הטיפולית. במקרים מסוימים אנליטיקאים אינם צריכים להמתין עד שיבקשו המטופלים לדעת מהי תגובת האנליטיקאי או תחושתו. יש רגעים שעל האנליטיקאים לעמת בהם את מטופליהם במישרין עם תגובותיהם הרגשיות, אם מבקש המטופל משוב כזה ואם לאו.

חשיפה עצמית וחרדת האנליטיקאי

דבר זה מביא אותי לטיעון נוסף כנגד חשיפה עצמית, שהייתי רוצה להתייחס אליו. גיל (Gill, 1983b) סבר כי כאשר אנליטיקאים מגלים דברים על עצמם, עליהם לבחון באופן אנליטי כיצד חווה המטופל את הדיווח. לדבריו, מוטב לנקוט גישה שמרנית ביחס לגילויים עצמיים, משום שהם עלולים לחסום חקירה נוספת של חוויית המטופל, בין היתר משום שחקירה כזו עלולה להוביל לחשיפת משהו בנוגע לאנליטיקאי שהמטופל היה מעדיף לא לדעת (Gill, 1983b, עמ׳ 228).

וכטל (Wachtel, 1993) מפתח נקודה זו וטוען כי הא־סימטריה המאפיינת את המצב האנליטי, וחירותו של האנליטיקאי לא לחשוף את האסוציאציות שלו, משמשות אמצעי הגנה המאפשרים לאנליטיקאי לעבוד באווירה שיש בה יחסית פחות חרדה, שכן האיום האישי הנוגע לחשיפתו שלו קטן. הוא טוען כי שמירת האנליטיקאי על זכותו לפרטיות משרתת בסופו של דבר את המטופל; אילו בכל פעם שאנו חושפים משהו מבייש או טעון בחרדה במטופל היינו חשים צורך לחשוף משהו דומה בנוגע אלינו, כי אז היה עלינו להיות בעלי עוצמה וטהור מופתיים כדי לעשות את עבודתנו. מאחר שאיננו כליל השלמות, הוא טוען, אנו זקוקים למבנה הא־סימטרי המגן עלינו מפני חרדתנו; כך נוכל להוסיף להתחקות

אחר סוגיות שונות, יהיה הכיוון שהן יובילו אליו אשר יהיה, תוך ידיעה שאנו עצמנו לא ניחשף. גם הופמן (Hoffman, 1994) מרחיב רעיון זה. הוא אומר:

> אחד הגורמים שמקדמים התחשבות **באנליטיקאי** הוא שהמטופל יודע עליו הרבה **פחות** ממה שהאנליטיקאי יודע על המטופל. האנונימיות היחסית תורמת לא רק להיבט האי־רציונלי של הכוח שיש לאנליטיקאי, אלא גם להיבט רציונלי יותר. אחרי ככלות הכול האנליטיקאי מצוי בעמדה מוגנת יחסית, שעשויה לקדם את ההיבטים הסובלניים, המבינים והנדיבים ביותר באישיותו (עמ׳ 199).

מה שמרגישים מחברים אלה הוא כי ההגנה שמספקת לאנליטיקאי אותה עמדה א־סימטרית של אנונימיות יחסית, היא בדיוק מה שמאפשר לו למלא את תפקידו כמיטב יכולתו, וכך נוצר בסיס אינטראקטיבי לאידאליזציה של המטופל את האנליטיקאי (Hoffman, 1994).

מקור מרכזי לבלבול סמנטי ומושגי נובע מזיהוי בין הסובייקטיביות של האנליטיקאי לגילוי עצמי. **בעיני, הבחירה לא לחשוף יכולה להיות לפעמים הדרך הטובה ביותר לבסס ולבטא את הסובייקטיביות של האנליטיקאי.** איננו צריכים להניח כי גילוי מכוון של תוכן מסוים בנוגע אלינו חושף אותנו יותר מאשר הבחירה שלא לגלות תוכן זה. הימנעות מגילוי היבט אחד של עצמנו יכולה להיות גילוי רב־עוצמה של היבט אחר שלנו. למשל, תשובה ישירה לשאלת מטופל עשויה להיראות כאקט של חשיפה עצמית, אך היא יכולה גם להיות ניסיון (מודע או לא־מודע) להסתיר חרדה או עוינות. כנות, אמת, פתיחות ואותנטיות הם תמיד רב־משמעיים. בשונה מהרעיון של ״עצמי אמִתי״, סובייקטיביות אינה מהות פשוטה ואחידה (מיטשל, 1993).

חשבו לדוגמה על מטופל ששואל את האנליטיקאית שלו מדוע התחילה את הפגישה באיחור של כמה דקות. האנליטיקאית, שמנסה במודע להיות פתוחה וישרה עם המטופל, עונה לו שהיא מצטערת על האיחור אך היא היתה עסוקה עם מטופל אחר שנמצא במשבר. תגובתו המִדית של המטופל היא תחושת פגיעה ודיכאון. הוא אומר לאנליטיקאית שהיא בוודאי ״ממש כועסת״ עליו. בתחילה האנליטיקאית מופתעת ומבולבלת. היא חוותה את עצמה כמשתדלת להיות ישירה וגלויה עם המטופל, ולא היתה מודעת כלל לתחושת כעס. אולם המטופל מציין כי לתפיסתו, האנליטיקאית סיפרה לו על מעורבותה עם המטופל השני כדי להעביר את המסר שבעיותיו של אותו מטופל דחופות וחשובות יותר מאלו שלו. הוא חש שהאנליטיקאית נחפזה כל כך לומר לו זאת, בלי לברר

כהרגלה מה משמעות השאלה עבורו, משום שרצתה לזרות מלח על פצעיו ולהבהיר לו שהיא עסוקה מאוד במטופלים אחרים. לאחר שהרהרה בדבר, עלה בדעתה של האנליטיקאית שיש אולי מידה מסוימת של צדק בדברי המטופל, ויחדיו הם הצליחו להתקדם הלאה.

אולם העלו בדעתכם את האפשרות שהמטופל לא היה מסוגל לעמת את האנליטיקאית עם הבחנה זו. מה בנוגע למטופל שהיה ממהר להדחיק מחשבה כזו והיה מקבל את תפיסתה העצמית של האנליטיקאית כנדיבה, אכפתית ובעלת כוונות טובות? לעתים ניתן ליישב אינטראקציות מסוג זה, והן מתגלות כמועילות; אך הן עלולות גם להכאיב למטופל שלא לצורך, ומה שאולי מסוכן ביותר – הן עלולות לכפות את תיאורו העצמי המודע של האנליטיקאי על המטופל. הנקודה היא כי חשיפות עצמיות, גם אלו שנעשות מתוך תחושה מְיֻדית של פתיחות, כנות וישירות מצד האנליטיקאי, מביעות הרבה יותר ממה שהאנליטיקאי התכוון אליו, ותמיד מטשטשות ומגלות גם יחד את הסובייקטיביות של האנליטיקאי, שהיא בהכרח מורכבת יותר מכפי שהאנליטיקאי יכול להעביר באמצעות חשיפה עצמית מסוימת. מורכבות זו אינה צריכה להביא למסקנה שמוטב להימנע מחשיפה עצמית, אלא להבנה שלא ניתן לייחס לחשיפה העצמית משמעויות פשוטות או מובָנות מאליהן יותר ממה שאנו מייחסים לאסוציאציות של המטופל.

ברור לי שאחד ההיבטים של בשלות כאנליטיקאי הוא ההכרה כי הרבה ממה שהיינו מעדיפים להסתיר הוא למעשה חשוף, וכי – אם אנו עובדים היטב – מטופלינו עשויים לגלות צדדים שלנו שאנו עצמנו טרם הִכרנו בהם. לא הייתי רוצה לעשות אידאליזציה של איכויותינו האישיות או של יכולותינו לאנליזה עצמית, אך בהחלט נראה לי שכדי שאנליטיקאים יעבדו היטב חייבות להיות להם לא מעט יכולת ונכונות לחשוף היבטים מעצמם המעוררים בהם חרדה, ולהכיל חרדה זו בצורה מספקת כדי להשתמש בחומר זה בעבודתם לטובת האינטרסים ארוכי הטווח של מטופליהם ושלהם עצמם. **אני טוען כי אחת הדרכים לחשוב על האיכות של "מומחיותנו" היא שכחלק מתפקידנו כאנליטיקאים נאפשר לעצמנו ונכין את עצמנו (באמצעות האנליזה שאנו עוברים במהלך ההכשרה) להיות פגיעים רגשית עם מטופלינו.** אני מסכים עם דברי לוונסון, שאנו האנליטיקאים מקבלים תשלום על כך שאנו פגיעים (מצוטט בתוך: Hirsch, 1992).

אינני חושב שאנליטיקאים יכולים לחשוף את עצמם בלי ללכת לאיבוד בתוך הסבך של ההעברה/העברה־נגדית; אני פשוט סבור כי יש ערך לתעייה בסבך זה, וכי המטופל והאנליטיקאי יחדיו יוכלו למצוא דרך להיחלץ ממנו. חלק ממומחיותנו האנליטית באה לידי ביטוי ביכולתנו הנרכשת לזהות באסוציאציות

של מטופלינו משוב על תפיסתם ביחס להשתתפותנו. לעתים מטופלינו יוכלו להיטיב לסייע לנו להבין כיצד השתתפנו אִתם אם נגלה נכונות לחלוק אִתם חלק ממחשבותינו, תחושותינו ותגובותינו. מובן מאליו שיש גבול ליכולות שלנו, אך אנונימיות אינה מספקת מפלט בטוח מהשתתפות. **אם במודל הקלאסי הרעיון הוא לעבור אנליזה טובה דיָה כדי לנטרל את השפעת בעיותיו האישיות של האנליטיקאי, ברצוני להציע כי במודל התייחסותי על האנליטיקאי לעבור אנליזה טובה דיָה כדי לשאת מידה מסוימת של חרדה ביחס לכך שחלקים נכבדים מאופיו ייחשפו וייבחנו על ידי מטופליו.** עלינו ללמוד לחוש בנוח עם תשוקותינו הסותרות: להכיר ולא להכיר את האחר, לאפשר לאחר להכיר אותנו ולמנוע ממנו להכיר אותנו.

הבנתנו מהי תובנה השתנה לבלי הכֵּר במשך השנים. מה שאנו רואים כיום כתובנה אינו מוגבל להבנת משמעות הדברים לגבינו – מה משמעות האסוציאציות שלנו, חלומותינו או הסימפטומים שלנו – כאילו משמעות זו מתקיימת בתודעתנו בלבד. כיום אנו ממקדים הרבה מתשומת לִבנו בהבנת ההשפעה הבינאישית שיש לנו על אחרים, והשפעת אחרים עלינו. לוונסון (Levenson, 1983) אִפיין שינוי זה כמעבר מהצגת שאלה למטופל "מה זה אומר?" להצגת השאלה "מה קורה כאן?" (עמ' ix). מה עושה לי המטופל ברגע זה, וכיצד אני לוקח חלק במה שמתרחש? אני יכול אולי להבין ברמה הוֹדּ־נפשית מהי משמעותו בשבילי של סמל המופיע בחלום, אך איני יכול להגיע לתובנה כיצד משפיע עלי אדם אחר באופן ייחודי בלי לדעת משהו על אותו אדם; ובדומה לכך, איני יכול להגיע לתובנה כיצד אני משפיע על אנשים אחרים, אם אינני מסוגל להבחין בפרטים רבים לגביהם. תובנה מסוג זה היא בינאישית ותלוית הֶקשר. היא מחייבת ששני אנשים יֵדעו פרטים חשובים זה על זה. תובנה זו היא בהכרח דו־סִטרית והדדית.

מטופלים רוכשים תובנה ביחס לאנליטיקאים שלהם, כחלק מהותי מרכישת ידע על עצמם. כיוון שהעצמי מתקיים בתוך קשר עם אחרים, תובנה ביחס לעצמי כוללת בהכרח גם תובנה לאחרים. התובנה שלי בנוגע לעצמי חייבת לכלול מודעות להשפעתי על אחרים ולהשפעתם עלי. כדי לקדם את מודעות מטופלי להשפעתם עלי ולהשפעתי עליהם, עלי להיות מוכן לאפשר להם להשפיע עלי, ללמוד ולנתח אותי באופן אנליטי, למען הצרכים האנליטיים **שלהם**. גילוי עצמי, כאחת מצורות ההשתתפות שהיא טכנית ואישית כאחת, עשוי הן להבהיר והן לטשטש את טבעה של האינטראקציה האנליטית. אין נוסחה טכנית – לא עקרון האנונימיות ולא חיוב לחשיפה עצמית – שתבטל את הצורך שהאנליטיקאי יגיע בכל רגע ורגע להחלטה אישית ומקצועית בנוגע לדרך הפעולה המתאימה

ביותר למאזן הכוחות בין המטופל לאנליטיקאי בנושאים של להכיר ולהיות מוּכָּר, להסתתר ולהימנע ממגע עם האחר, להסתכן ולמצוא ביטחון. על החלטה זו לשמר גם את המתח האופטימלי בין קשר אישי וקשר טכני. התוצאה של כוחות אלה בשני המשתתפים היא שתקבע אם וכיצד תקדם התערבות כלשהי את התהליך האנליטי.

סיכום: חשיפה עצמית ואותנטיות

היו זמנים, לפני עשרות שנים, כאשר היו לפסיכואנליטיקאים אמונות בסיסיות מקובלות כיצד יש לעשות אנליזה. הם ידעו כי על האנליטיקאי להיות אנונימי, מסך חלק; כי עליו להימנע מלהיות מספק מדי, והוא צריך לשמור על ניטרליות, ולָא להגיב באופן המושפע מהעברת המטופל. כשאנליטיקאים החלו להטיל ספק בחלק מהנחות היסוד שבבסיסן של המלצות טכניות אלה, ובייחוד כשהחלו להמעיט בחשיבותה של תובנה לבדה ובמקום זה הדגישו את חשיבות הקשר, גבר הפיתוי לזנוח חוקים וכללי יסוד אלו. לאנליטיקאים מסוימים נראה שהדבר החשוב באמת הוא חיבור עמוק הכרוך במעורבות אישית אינטנסיבית עם המטופל, קשר המבוסס על תגובתיות רגשית, מפגש קיומי.

יש נטייה חזקה לעבור מקיצוניות אחת לאחרת, לנוע בין ראיית האנליזה כמפגש אישי, שבו חוקים וקווים מנחים רק מכשילים ומפריעים, לבין ראיית האנליזה כהליך טכני מוסדר ומוגבל, לא אישי מדי, שכולל בתוכו ברית טיפולית תחומה ומצומצמת. המשימה שלקחתי על עצמי בפרק זה היתה להקדיש מחשבה לסוגיית החשיפה העצמית, בלי להיתפס באחת משתי מלכודות אלה למשך זמן רב מדי. אינני מסכים עם העמדה השמרנית יותר, שלפיה אל לו לאנליטיקאי לגלות דבר על עצמו בשום נסיבות כמעט; אך גם איני מרגיש ממש נוח עם גישה של "הכול הולך", שממנה משתמע כי האנליטיקאי יכול לומר או לעשות ככל העולה על רוחו, כל עוד הדבר זוכה ל"ניתוח אנליטי" או מדברים עליו. כפי שציינו אינדרביצן ולוי (Inderbitzin & Levy, 1994), לא כל דבר "מספק גרעינים לטחנה". אנליטיקאים עשויים לנסות לנתח כל דבר באנליזה, אך לא כל דבר ניתן לניתוח אנליטי (עמ' 764).

מיטשל (Mitchell, 1995) נוקט עמדה דומה, כשהוא מעמת את העמדות הבינאישיות והקלייניאניות בנוגע לאינטראקציה בפסיכואנליזה. מיטשל רואה את הקלייניאנים כמי שמדגישים איפוק של האנליטיקאי ועיבוד שקט של תגובותיו הרגשיות, הכלה של ההעברה־הנגדית ושימוש בה לצורך גיבוש פירוש הולם. בניגוד לכך, מתאר מיטשל אנליטיקאים בינאישיים כמי שנכונים יותר

לבטא ישירות את תגובותיהם הרגשיות המִיָדיות בצורת חשיפה עצמית. מיטשל מנסה לפייס בין שני קצוות אלה, והוא סבור כי לכל אחד מהם יש יתרונות וחסרונות. מוצאים חן בעיניו האלמנטים של ספונטניות, חירות וכנות רגשית שמציעה האסכולה הבינאישית, אך הוא מעריך את הכלת ההעברה־הנגדית ואת העיבוד הרגשי המאופק של הקלייניאנים. תוך שהוא שוקל את יתרונות השיטה הקלייניאנית, מציין מיטשל כי כאשר אנליטיקאי חושף רגש מסוים בפני מטופל, אותו רגש עשוי לייצג היבט של המטופל שנותק באופן דיסוציאטיבי (והופקד אצל האנליטיקאי באמצעות הזדהות השלכתית). בחשיפת הרגש בפני המטופל האנליטיקאי עלול להגביר את הניתוק של המטופל מרגש זה בתוכו. מיטשל מציע כי בהכלת הרגש, במקום ביטויו הישיר, עשוי האנליטיקאי לעודד את מטופליו לחוות את הרגש כשייך להם.

מטיעונו של מיטשל משתמע כי בעזרת הכלה, החזקה, עיבוד ועיכול של חוויותיו הרגשיות המִיָדיות, מתאפשר לאנליטיקאי להתעלות על תגובותיו האינדיבידואליות הרגעיות, ולהשיג הבנה טובה יותר של מקומם של רגשות אלה בהקשר הרחב יותר של האינטראקציה ארוכת הטווח עם מטופליו. הוא כותב: "התבוננות אנליטית מחייבת הפניית תשומת הלב להיבטים של רגשות האנליטיקאי כלפי המטופל, שהם שונים מאלה שעשויים לעמוד בקִדמת הבמה ברגע נתון" (עמ' 195). תגובה אימפולסיבית אינה בהכרח **אותנטית** יותר מתגובה מאופקת ושקולה: "האותנטיות אצל האנליטיקאי קשורה פחות באמירת הכול, ויותר באמִתות של מה שנאמר" (עמ' 195).

אני מסכים לגמרי עם מיטשל שאין לזהות אותנטיות עם צורך כפייתי לדבר בצורה אימפולסיבית עם מטופלים; אך בעיית האותנטיות מורכבת לאין שיעור. אחרי ככלות הכול, האומנם קל יותר לקבוע אם מה שנאמר "אמִתי" מאשר לפסוק מה "אותנטי"? מה שייראה כביטוי של אותנטיות וספונטניות בעיני אנליטיקאי אחד, יכול להיתפס על ידי אנליטיקאי אחר כאימפולסיביות או כעיסוק בסיפוק צרכיו שלו. מה שאנליטיקאי אחד חווה כאיפוק מתוך משמעת עצמית וכהחזקה ועיבוד של רגשות, אנליטיקאי אחר עלול לחוות כ"ישיבה בחיבוק ידיים", מחנק, דיכוי רגשי, אי־מעורבות אישית והישענות על סמכות. מיטשל מציע בחוכמה שילוב של שתי הגישות, כדי לאזן בין איפוק, שיקול דעת ומשמעת עצמית לבין החיוניות שבספונטניות ובביטוי רגשי משוחרר.

באופן מסורתי ציפו מן האנליטיקאי לשמור על עמדה בסיסית של אנונימיות יחסית (אם לא מוחלטת), אך לאחרונה נשמעת הדעה כי עמדה זו עלולה לסכל עבודה אנליטית יעילה. לרר (Lehrer, 1994), למשל, הציע: "אפשר שיימצא כי עמדה בסיסית של היענות אנושית וחשיפה עצמית ביחס לאינטראקציה

הטיפולית מספקות בסיס קונסטרוקטיבי יותר" לאנליזה (עמ' 514). אינני מאמין כי קיימת דרך אחת נכונה כלשהי לעשות אנליזה, כפי שאינני סבור שיש מידה "נכונה" של חשיפה עצמית, שהיא האופטימלית. ניסוחו של לרר "היענות אנושית וחשיפה עצמית" קושר בין שני המונחים, וניתן להבין ממנו כי אין זה אנושי **לא** להגיב או להיחשף; **אינני** חושב שאלו הם תמיד פני הדברים. ייתכן כי אנליטיקאים מסוימים חשים נוח יותר עם עמדה בסיסית של אנונימיות יחסית, אך חשוב שגם אנליטיקאים אלה יהיו גמישים דיים כדי לחרוג מעמדה זו במקרים מסוימים, עם מטופלים מסוימים. עבור אנליטיקאים אחרים נוחה יותר ואֲפקטיבית יותר עמדה בסיסית של היענות יחסית וחשיפה עצמית בנוגע לאינטראקציה הטיפולית; אך גם לאנליטיקאים אלה חשובה הגמישות לחרוג מן העמדה הבסיסית ולשמור על מידה מסוימת של מרחב פרטי.

.. תהיה ההחלטה שתתקבל בכל מקרה נתון אשר תהיה, ויהיה הסגנון המתאים ביותר לאישיות האנליטיקאי המסוים אשר יהיה, עליהם להישאר פתוחים להתבוננות ולאנליזה של שני המשתתפים. אף אחד מהסגנונות הטכניים אינו אנושי יותר, או בעל יעילות טיפולית גבוהה יותר, מן האחר. יש להביא בחשבון משתנים רבים מדי מכדי להגיע לפתרון מוחלט שיתאים לכל אחד. אני סבור כי זהו היבט אחד של מה שפרנצי (1928) כינה "האלסטיות של הטכניקה הפסיכואנליטית". עם הגורמים שעל האנליטיקאי לקחת בחשבון כשהוא בוחר מתי וכמה לחשוף את עצמו נמנה המאזן היחסי של קונפליקטים סביב רצונותיהם של המטופל והאנליטיקאי להכיר ולהיות מוּכָּרים.

מה שמרגש ביותר בהתפתחויות העכשוויות בתאוריה ובפרקטיקה הפסיכואנליטיות הוא הפתיחות החדשה לפלורליזם ולשונות. יש הרבה דרכים אֶפקטיביות לעשות פסיכואנליזה, ולא רק דרך אחת. אנליטיקאים בוחרים בין אפשרויות רבות של טכניקה, וכל אחד מאִתנו יכול לבחור אחרת ועדיין להצליח לעשות אנליזה טובה, כל עוד גישתנו התאורטית והטכנית מתאימה לנו או משלימה אותנו. אינני סבור שמצאנו גישה אחידה וסופית לטכניקה הפסיכואנליטית, ואני מקווה שלעולם לא נמצא! תאוריה של טכניקה טיפולית הדורשת חשיפה עצמית (הכוונה היא לחשיפה החורגת מהבלתי נמנע) מגבילה לא פחות מתאוריה האוסרת על כך. אין תשובות נכונות בנוגע למה ראוי לחשיפה עצמית מצד האנליטיקאי או מתי נכון לעשות זאת. אין תשובות שאינן תלויות במטופל האינדיבידואלי, או – חשוב מכך – באופיו של האנליטיקאי. לפיכך הצעתי הטכנית היא פתוחה ואינה ספציפית. אני סבור שעל שאלת מידתו וטבעו של הגילוי העצמי המכוון של האנליטיקאי יש לענות מתוך ההקשר של כל מצב אנליטי ייחודי. שום תאוריה ביחס לטכניקה אינה יכולה ללכת מעבר

לאופיו הייחודי של האנליטיקאי. נראה לי כי יש אנליטיקאים מעולים הנוקטים רק לעתים רחוקות חשיפה עצמית תכליתית, ואנליטיקאים מעולים הבוחרים בה לעתים קרובות. תאוריה של הטכניקה אינה יכולה להכתיב חשיפה עצמית בלי להביא בחשבון מה משמעותה לאנליטיקאי האינדיבידואלי, ולא כל שכן מה משמעותה למטופל ולדיאדה הטיפולית הייחודית.